

Préparation au concours

www.ispits.net

- **Q) l'organisation de la direction régionale:**

- Directeur régional de la santé
- Sce des équipements et de la maintenance
- Sce des RH et contentieux
- Sce de l'offre de soins
- Sce de la santé publique
- Sce des RF, logistiques et partenariat
- Observation régionale de soins
- Unité régionale d'approvisionnement et de la pharmacie
- Unité régionale de communication et d'informatique

- ❑ **la délégation préfectorale/ provinciale:**

- Délégué
- Sce administratif et économique: (RH, RF, équipement, maintenance, parc auto)
- SRES:
 - ✓ RESSP
 - ✓ REH
 - ✓ REMS
 - ✓ RISUM

- **Q) en 2013 le ministère de la santé** constitue le 1er prestataire de soins (77% de la CL du pays) et ne bénéficie que d'environ 27,3 du financement du SNS
- **Q) La classification des hôpitaux:**
 - ✓ Selon l'orientation technique ou spécialisation
 - ✓ Selon le niveau d'intervention ou niveau de recours (territoire)
 - ✓ Selon le mode de gestion ou statut
 - ✓ Selon la capacité d'accueil
- 1) **Selon la spécialisation: (la gamme des prestations et la nature des équipements)**
 - ☐ Hôpitaux généraux :
 - ☐ •Hôpitaux spécialisés: (Exemple : Les Hôpitaux psychiatriques ; Les Centres régionaux d'oncologie ; Les Centres d'hémodialyse)
- 2) **Selon le niveau de recours:**
 - 1.CHP: Hôpitaux de recours provincial : y compris les HP
 - 2.CHR: Hôpitaux de recours régional
 - 4.Hôpitaux universitaires de recours interrégional ou de référence nationale

3) Selon le statut ou le mode de gestion: on distingue 3 types:

- ❖ Les hôpitaux dits « en régie » ou SEGER: exp les centres de santé:
 - Dépendance statutaire et financière au MS.
 - Ne disposent pas de personnalité morale, et liés au programme d'exécution du MS.
 - Leurs ressources financières sont des crédits délégué par le département sur la budget général.
 - Pas de virement de crédit d'un article à un autre
- ❖ Les hôpitaux érigés en service de l'état géré de manière autonome « SEGMA »: exp: CHR:
 - Ne jouissent pas de personnalité morale
 - Jouissent d'une autonomie financière
 - Ils réutilisent leurs recettes
 - Leurs dépenses obéissent aux règles de la compatibilité publique
 - Formule intermédiaire entre la gestion en régie et la gestion autonome
 - Bénéficie d'une subvention de l'état
 - Ils sont soumis à la subordination de l'administration centrale

❖ Les hospitaliers érigés en établissements publics administratifs: (CHEEPA): (autonomes): exp CHU:

- Dotés de personnalité morales et juridique
- Peuvent effectuer des virements de crédits d'un article à un autre mais dans un même chapitre
- Ils ont une indépendance à la fois financière et administrative
- Peuvent utiliser leurs recettes
- Peuvent recevoir des legs et des dons
- Ils se trouvent soumis à certains contrôles de l'état et au respect des principes fondamentaux du service publics (la tutelle)

4) Selon la capacité d'accueil :

3 catégories d'hôpitaux:

- ❖ Hôpitaux de <120 lits (77 hôpitaux) : 08 services
- ❖ Hôpitaux de 120 à 240 lits (25 hôpitaux) : 06 départements et 03 services
- ❖ Hôpitaux de >240 lits (20 hôpitaux) : 08 départements et 02 services
- **Q) La moitié des dépenses des ménages par prestataire pour l'année 2010 est effectuée auprès:** des pharmacies et des fournisseurs de soins en terme d'achat des médicaments et des bien médicaux.
- **Q) La source principale du financement du MS:** est le budget de l'état 72,5% en 2013 (75% en 2010)

- **Q) la part la plus importante des dépenses du MS en 2013 est allouée:**
aux hôpitaux (31,8%° y compris CHU (21,3%) 53,1% (et 47% en 2010)
- **Q) Depuis l'entrée en vigueur de loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base le 18/8/2005:**
 - Le CNOPS gère le régime d'AMO au profit des fonctionnaires et agents actifs et retraités du secteur public et leurs ayants droit.
 - La CNSS gère le régime d'AMO au profit des salariés actifs et des retraités du secteur privés et leurs ayants droit.
- **Q) la couverture médicale du personnel du secteur public est assurée essentiellement par des sociétés mutualistes fédérées au sein de la CNOPS, et qui sont:** au nombre de 8.
- **Q) l'évaluation qualitative:** est analyse de la qualité d'un acte de soins:
 - Conséquences en terme des résultats et la satisfaction des patients
 - Conséquences en terme des ressources consommées par le soin
 - Conséquences en terme d'efficacité du soin
- **Q) l'évaluation de la qualité d'un soins:** englobe l'évaluation des résultats et l'évaluation des ressources.

- **Q4) l'organisation du RISUM:** (NB: leur régulation est assuré par les SAMU)
- ✓ **les Urgences Médicales de Proximité (U.M.P):** assurées par les centres de santé de deuxième niveau implantés dans les chefs-lieux de cercles (représente le 1^{er} niveau du RISUM):

Assurent les 7 fonctions suivantes:

- ❖ F1: permanence 24 h/24
- ❖ F2: diagnostic des détresses vitales
- ❖ F3: gestes et manœuvres de premier secours
- ❖ F4: contention provisoire et immobilisation de fractures par attelles
- ❖ F5: surveillance du patient
- ❖ F6: examen biologique de base
- ❖ F7: transfert sanitaire simple 24h/24
- ✓ **les Urgences Pré-hospitalières (UPH):** assurées par les moyens de transport de secours de base, les services médicaux d'urgence et de réanimation(SMUR) et les services médicaux héliportés (HELISMUR);

✓ les Urgences médico-hospitalières (UMH): Comprennent:

1) Les urgences médico-hospitalières de base (UMHB) assurées par les HP, CHP, (représente le 2ème niveau du RISUM)

Assurent les fonctions F8 à F12:

- ❖ F8: geste de ressuscitation et de réanimation
- ❖ F9: examen complémentaire de base
- ❖ F10: transfusion
- ❖ F11: hospitalisation
- ❖ F12: intervention chirurgicale

2) Les urgences médico-hospitalières complètes (UMHC) assurées par les CHR, et les CHU

(représente le 3ème niveau du RISUM):

Assurent les fonctions F13 à F16:

- ❖ F13: fonction de réanimation hospitalière polyvalente
- ❖ F14: examens complémentaires complets
- ❖ F15: transfert SMUR en plus de F9
- ❖ F16: régulation des appels médicaux

3) Les urgences médico-hospitalières spécialisées (UMHS) assurées par les CHIR.

Assurent les fonctions suivantes:

- ❖ Urgences obstétricales, urgences psychiatriques
- ❖ PEC des brûlés, oxygénothérapie hyperbare...
- **les composantes du RISUM:**
 - les Services d'urgence hospitaliers (SUH) ;
 - Le Service d'Assistance Médicale Urgente (SAMU) avec son Centre de Régulation des Appels Médicaux (CRAM) et son Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence (CESU). Cette structure pouvant être commune à plusieurs régions ;
 - les Services Mobiles Hospitaliers d'Urgence et de Réanimation dits SMUR ;
 - les Structures de Soins de Santé de Base participant aux activités médicales urgentes ; (CS de 2eme niveau)
 - les moyens de transport sanitaire mobilisés par le CRAM dans le cadre de l'activité d'Assistance Médicale Urgente (AMU).
- **Q) l'analyse du coût ou de minimisation du coût:** tend à déterminer la quantités des ressources consommées¹ par une pathologie donnée

- **Q) Les personnes reconnues éligibles au RAMED ont droit :** Aux prestations médicalement requises dans les structures sanitaires relevant de l'état
- **Q) Classification fonctionnelle des dépenses de santé (CNS 2013):**
 - 38% des dépenses aux soins ambulatoires (29,4% en 2010)
 - 26,2% des dépenses aux médicaments et biens médicaux (31,7% en 2010)
 - 23,2% des dépenses aux soins hospitaliers (25,4% en 2010)
 - 7,8% des dépenses à l'administration
 - 2,2 % des dépenses à la prévention sanitaire collective
 - 1,6% des dépenses à la formation, recherche, enseignement
 - 1% des dépenses aux autres prestations
- **Q) dans le domaine de la santé, l'évaluation quantitative des soins:** est une analyse comparative d'actions alternatives en terme de cout et de conséquences sur la santé, utilise les indicateurs suivants:
 - L'analyse du rapport coût/ efficacité
 - L'analyse du rapport coût/ utilité
 - L'analyse du rapport coût/ bénéfice

- **Q) Les critères d'éligibilité pour bénéficier du RAMED**

- **En milieu urbain:**

- ❖ **Le critère 1:** Disposer d'un revenu annuel inférieur à 5650 DH/Personne composant le ménage après pondération du revenu déclaré, y compris les transferts, par des variables socio-économiques du ménage
- ❖ **Le critère 2:** Avoir un score des conditions socio-économiques ≤ 11 .
- ❖ **Le critère 3:** taux de pauvreté de la commune ≥ 30 (critère supprimé)

- ❖ **En milieu rural:**

- **Le critère 1:** Avoir un score patrimonial ≤ 70 par personne composant le ménage.
- **Le critère 2:** Avoir un score des conditions socioéconomiques ≤ 6

- **Q) les catégories de bénéficiaires du RAMED:**

- ❖ **ED situation de pauvreté:**

- Milieu urbain: Revenu pondéré ≤ 3767 DH
- Milieu rural: indice patrimonial ≤ 28 points

- ❖ **ED en situation de vulnérabilité:**

- Milieu urbain: Revenu pondéré $> \text{à } 3767$ DH et $\leq \text{à } 5650$ DH
- Milieu rural: indice patrimonial $> \text{à } 28$ points et $\leq \text{à } 70$ points

- **Les prestations exclues du champ d'AMO**
 - les interventions de chirurgie esthétique,
 - les cures thermales,
 - l'acupuncture, www.ispits.net
 - la mésothérapie,
 - la thalasso thérapie,
 - l'homéopathie et les prestations dispensées dans le cadre de la médecine
 - dite douce.
- **Pour décontaminer le matériel souillé/** on utilise l'hypochlorite de sodium à 0,5%
- **les organes hématopoïétiques:**
 - La moelle osseuse (tissu myéloïde)
 - Le tissu lymphoïde (thymus, ganglions lymphatiques, amygdales, rate, les amygdales, plaques de peyer et les follicules clos)

- **Q) Les bénéficiaire de l'AMO:**

- Fonctionnaires et agents de l'état, des CL, établissements publics, et des personnes morales de droit public
- Personnes assujetties au régime de sécurité sociale (secteur privé)
- Retraités du secteur public et privé
- Travailleurs indépendants et les libéraux, et personnes exerçant une activité non salariée
- Anciens résistants et membre de l'armée de libération
- Etudiant de l'enseignement supérieur public et privé
- Les membres de la famille du l'assuré:
 - ✓ Le conjoint
 - ✓ Les enfants à charge de l'assuré, âgés de 21 ans au plus jusqu'à 26 ans en cas de poursuite des études dument justifiées
 - ✓ Les enfants handicapés sans limite d'âge
 - ✓ L'assuré peut demandé l'extension du bénéfice d'AMO dont il relève à son père et sa mère à conditions de prendre en charge la cotisation les concernant.

- **Q) Les bénéficiaires des prestations du RAMED sont:**
 - ❖ B. sur demande (par éligibilité):
 - les personnes qui ne sont assujettis à aucun régime d'AMO et ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses inhérentes aux prestations médicales.
 - Leur(s) conjoint (s)
 - Leurs enfants handicapés quel que soit leur âge, qui sont dans l'impossibilité totale et permanente de se livrer a une activité rémunérée par suite d'incapacité physique ou mentale
 - leurs enfants a charge, non salaries, âges de 21 ans au plus et non couverts par une assurance maladie obligatoire de base. Cette limite d'âge peut être prorogée jusqu'a 26 ans en cas de poursuite des études dument justifiées;
 - Les enfants qui vivent sous le même toit que les personnes bénéficiaires citées ci-dessus, et qui se trouvent a leur charge effective, totale et permanente, sont, a condition d'en apporter la preuve, admis au bénéfice des prestations garanties au titre du RAMED.

❖ B. de droit:

- Les pensionnaires des établissements de bienfaisance (الإحسان), les orphelinats (دار الأيتام), les hospices (دور العجزة) ou des établissements de rééducation et de tout établissement public ou privé à but non lucratif hébergeant des enfants abandonnés ou adultes sans famille
- Les pensionnaires (les retraités) des établissements pénitentiaires (les prisons)
- Les personnes sans domiciles fixes
- Les personnes bénéficiant de la gratuité par la loi (pupilles de la nation, les anciens militaires et anciens combattants, les malades indigents étrangers)
- **Q) La responsabilité pénale du professionnel de santé est engagé en cas de :**
 - Omission de porter secours à une personne en danger
 - Homicide involontaire
 - Violation du secret professionnel
 - Exercice illégal de la profession

Q5) la part la plus importante du financement du système national de santé: est assurée par les ménages ou bien les paiements directs des populations.

• **Q) le RAMED couvre les prestations médicalement requises suivantes:**

- Soins préventifs
- Actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales.
- Soins relatifs au suivi de la grossesse, à l'accouchement et ses suites.
- Soins liés à l'hospitalisation et aux interventions chirurgicales y compris les actes de chirurgie réparatrice.
- Analyse de biologie médicale
- Radiologie et imagerie médicale
- Explorations fonctionnelles
- Médicaments et produits pharmaceutiques administrés pendant les soins
- Poches de sang humain et ses dérivés
- Dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux
- Articles de prothèse et d'orthèse
- Lunetterie médicale
- Soins bucco-dentaires
- Orthodontie pour les enfants
- Actes rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie
- Actes paramédicaux
- Evacuations sanitaires inter-hospitalières.

www.ispits.net

- **Q) les établissements du Croissant Rouge Marocain** font partie du Secteur privé à but non lucratif
- **Q) Au Maroc, le budget total du MS:** représente 5,3% du budget total de l'état (2015). Sachant qu'au niveau international l'amélioration du secteur de la santé nécessite 12% du budget général de l'état.(5,61% en 2016)
- **Q) la performance d'un système de financement de la santé se mesure à sa capacité de:**
 - Générer des ressources suffisantes et pérennes pour la santé (plus de d'argent pour la santé)
 - Faire un usage optimal de ces ressources (plus de santé pour son argent)
 - Veiller à ce que les services de santé soient financièrement accessibles à tous.
- **Q) les déterminants clés de la performance des systèmes de financement de la santé:**
 - L'importance des prépaiements
 - Le degré de répartition des risques financiers (financement collectif)
 - La subvention des pauvres
 - Stratégie d'achat des prestations

- **Q3: les dimensions à considérer dans la progression vers la couverture sanitaire universelle sont:**
 - La largeur de la couverture (le type et la proportion de la population qui est couverte)
 - La profondeur de la couverture (les services couverts jusqu'à la chirurgie esthétique)
 - La hauteur de la couverture (la proportion du couts qui est couverte)
- **Q) la DMS est un indicateur de performance hospitalière qui renseigne sur:** La productivité. Elle correspond au nombre de journées de soins (d'hospitalisation) divisé par le nombre d'hospitalisation.
- **Q) les objectifs de l'économie de la santé:**
 - Rechercher la meilleure utilisation des ressources
 - Proposer des solutions aux problèmes économiques et financières de la santé
- **Q) définitions:**
 - **Le cout:** l'ensemble de dépenses nécessaires à la production d'un bien ou d'un service ainsi que l'usure ou l'obsolescence = التقادم (amortissement) des immobilisations nécessaires à cette production.

- Le prix: la résultante de la confrontation de 2 forces contraires offre/demande.
- La tarif: prix fixé institutionnellement par une autorité pour des raisons économiques ou sociales.
- **Q) les comptes nationaux de la santé:**
 - incluent toutes les parties jouent un rôle dans le financement.
 - Constituent une approche globale examinant le montant total des dépenses de santé au niveau national.
- **Q) les dimensions de la qualité en santé:**
 - L'innocuité de soins
 - La compétence humaine ou compétence professionnelle des soins
 - L'efficacité
 - L'efficience
 - La sécurité
 - La continuité
 - L'accessibilité/ équité
 - Les relations interpersonnel (la réactivité et l'empathie...)
 - L'agrément des services de santé

- **Q) l'énoncé du problème dans un cycle d'amélioration de la qualité doit:**
 - Evoquer la source d'information sur le problème
 - Évoquer la fréquence du problème
- **Q) les catégories des déterminants de la santé:**
 - Mode ou habitudes de vie
 - Environnement
 - Facteurs biologiques
 - Organisation de soins
- **Q) l'intégration des soins est une:**
 - Intégration dans le temps
 - Intégration dans l'espace
 - Intégration des services dans le système de santé (district)
- **Q) les études épidémiologiques sont classées selon:**
 - Le temps
 - L'élément de départ
 - L'objectif de l'étude
 - Les moyens d'investigation

- **Q) une étude transversale est une étude épidémiologique:** de prévalence
- **Q) la proportion:** est un rapport ou le numérateur est compris dans le dénominateur pendant un temps donné.

- **Q) les fonctions d'un système de santé:**

1. Fonction Prestation de soins et services de santé
2. Fonction ressources humaines
3. Fonction financement de la santé
4. Fonction gouvernance et leadership
5. Fonction système d'information et métrologie sanitaire
6. Fonction technologie sanitaire et bien médicaux

FE

- **Q) la prévalence:** le nombre de cas existant dans une population donnée à un moment donné. (désigne l'état de santé d'une population à un moment donné)

$$\frac{\text{Nombre de cas en cours (M) (t) } \times 100}{\text{Pop moyenne exposé}}$$

- **Q) l'incidence:** le nombre total des nouveaux cas dans une période donnée (t) * (k) / la population moyenne exposée au risque à la même période (t)

- **Q) Les domaines d'action prioritaires qui contribuent à réaliser l'objectif de l'OMS relatif au 'vieillessement en bonne santé':**
 - Harmoniser les systèmes de santé aux besoins de la population
 - Développer les systèmes de soins spécifiques
 - Créer des environnements facilitateurs pour les personnes âgées
 - Améliorer l'évaluation les méthodes de surveillance et la compréhension
 - **Q) un soin efficace se caractérise par:**
 - La continuité
 - La globalité
 - L'intégration

} **qualité organisationnelle**

 - L'efficacité (faire les choses bien)
 - efficacité (faire les bonnes choses)
- } **qualité technique**
-
- Une bonne communication professionnelle de sante / population
- qualité relationnelle**

- **Q) les caractéristiques d'un service de soins sont:**
 - Décentralisation
 - Permanence
 - Polyvalence
- **Q) l'évaluation des politiques en santé publique vise à:**
 - Juger du succès ou de l'échec d'une action
 - Améliorer l'ensemble du processus de planification
- **Q) les critères de priorisation d'un problème de santé:**
 - Fréquence (ampleur)
 - Gravité: mortalité, conséquences fonctionnelles
 - Vulnérabilité
 - L'urgence
 - Impact socio-économique
 - Perception sociale
 - L'évolution dans le temps
- **Q) selon le modèle de PATHWAY de l'OMS 2011:** les déterminants intermédiaires de la santé sont: les facteurs humaine, biologiques, psychologiques et matériels.

- **Q) la santé communautaire:** Fait partie intégrante de la santé publique. Sa spécificité est d'être populationnelle et non individuelle et de promouvoir et de mettre en œuvre une vision globale et de proximité de la santé. Elle est fondée sur plusieurs grandes principes:
 - La santé est liée à un ensemble de facteurs (démographiques, géographiques, sociaux, économiques ...) qui ne touche pas qu'un individu mais toute une population et qui sont réparties de manière inégale entre les territoires.
 - La médecine, le système de soins et les politiques publiques n'apportent pas toujours une approche assez globale
 - Les comportements individuels sont difficiles à faire changer donc l'implication des gens est fondamentale pour parvenir à un changement: *il ne s'agit pas de faire pour les gens mais avec eux.*
- **Q) Le Développement de la participation communautaire nécessite :**
 - a. Elaboration d'une stratégie sur la santé communautaire
 - b. Renforcement des compétences en matière de participation et d'action communautaire
 - c. Etendre les expériences communautaires réussies
 - d. Mobilisation de la société civile autour de la santé communautaire

- **Q) les indicateurs de l'état de santé:**

- 1) **Les indicateurs démographiques**

- L'espérance de vie à la naissance
- Taux d'accroissement démographique annuel
- TB de natalité
- IS de fécondité

- 2) **Les indicateurs de morbidité**

- Taux d'incidence
- Taux de prévalence

- 3) **Les indicateurs de mortalité**

- Taux bruts de mortalité: nombre de décès/ nombre totale de la population
- Taux spécifiques de mortalité: (l'âge, sexe, causes)
- Mortalité prématuré= mortalité avant 65 ans
- Taux de Mortalité Infantile
- Taux de Mortalité Juvénile
- Taux de Mortalité Infanto-Juvénile
- Taux de Mortalité Maternelle

- **Q) l'efficacité exprime:** le degré de réalisation des objectifs et cibles prédéterminées d'un programme.

- **Q) les indicateurs de la prestation de soins de santé:**

- La disponibilité
- Utilisation des services

- **Q) les acteurs impliqués dans le diagnostic communautaire sont:**
 - La population / la communauté
 - Les agents de développement / les médiateurs
 - Les professionnels et les experts
 - Les décideurs et les élus
- **Q) les problèmes essentiels rencontrés par le Maroc pour aboutir à une couverture sanitaire universelle de santé:** faisant partie des états membres de l'OMS le Maroc s'est engagé également en 2005 à développer son système de financement de la santé afin que tout un chacun puisse accéder aux services, sans subir de difficultés financières lors de leur paiement. Cet objectif a été défini comme la couverture universelle, parfois appelée la couverture universelle de santé. Pour progresser vers cet objectif, le gouvernement marocain est entrain de faire face à trois problèmes essentiels:
 - La disponibilité des ressources suffisantes
 - La dépendance excessive aux paiements directs au moment où les personnes ont besoin de soins
 - L'utilisation efficiente et équitable des ressources

- **Q) la caisse nationale des organismes de prévoyance sociale gère l'AMO pour:**

www.ispits.net

- Les étudiants (13/1/2016 CNOPS)
- Les anciens victimes des violations des droits de l'homme (4/1/2007 CNOPS)
- Les agents de l'autorité et les anciens membre de la résistante et de l'armée de libération (1/2008 les sociétés d'assurance)
- Les indépendants et les professions libres (7/1/2017 CNSS)
- Le secteur public (CNOPS 18/8/2005)
- Le secteur privé (CNSS 18/8/2005)

RAMED: pour les catégories sociales indigentes (ANAM 13/3/2012 généralisation / expérience fait en 4/11/2008 Tadla azilal)

64% de la population marocaine a une couverture médicale maintenant

- **Q) Le financement du RAMED est assuré par:** l'état (75%), les collectivités locales (6%), la cotisation des bénéficiaires (19%)

- **Q) les objectifs d'un SS:**

- ✓ Améliorer la santé de la population desservie
- ✓ Répondre aux attentes des gens (avec respect et dignité)
- ✓ Assurer la protection financière contre les couts de la mauvaise santé

- Q) selon les comptes nationaux de la santé 2010, les dépenses des ménages ont été consacrées par ordre décroissant pour les prestations suivantes: Pharmacie et fournisseurs de biens médicaux, hospitalisation, consultations médicales, analyses médicales
 - Q) selon les comptes nationaux de la santé 2010 les dépenses de la coopération internationale ont été orientées essentiellement vers: l'investissement
 - Q) les 3 causes à l'origine de plus de la moitié des décès néonatales survenus les 48 premiers heures de la vie sont:
 - Les anomalies liées à une brièveté de la gestation
 - L'hypoxie intra-utérine
 - Les infections spécifiques de la période périnatale
 - Q) le plan d'action national sur la santé et l'handicap 2015-2021 comprend: 6 axes et 20 mesures.
 - Q) le RAMED: cible 8,5 millions de citoyen en situation de pauvreté et de vulnérabilité
 - La cible tensionnelle systolique à atteindre chez les sujets de plus de 80 ans: < 150 mm Hg
- le traitement d'urgence d'une brûlure consiste à: refroidir la brûlure avec de l'eau du robinet + pommade.

- **Q) les 8 principes réagissent l'OS et la CS:**

- 1) La solidarité et la responsabilisation de la population dans la prévention, la conservation et restauration de la santé
 - 2) L'égalité d'accès aux soins et services de santé
 - 3) L'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires
 - 4) La complémentarité intersectorielle
 - 5) L'adoption de l'approche genre en matière de services de santé
 - 6) L'intégration et la coordination
 - 7) La globalité
 - 8) La gradation des soins
- 
- Principes
des SNS

- **Q) Le processus théorique d'élaboration du Schéma Régional de l'Offre de Soins peut être résumé en trois étapes essentielles, qui sont:**

- L'identification des problèmes et la fixation des grandes orientations
- La mobilisation des ressources
- La détermination des mesures à prendre

- **Q) épidémie:** Une augmentation significative et inhabituelle de la fréquence d'une maladie dans le temps et dans l'espace est une:

- **Q) les 6 axes du plan d'action national sur la santé et le handicap 2015-2021:**
 - le renforcement des programmes et des actions de prévention et de dépistage précoce des pathologies à l'origine du handicap.
 - L'amélioration de la PEC des besoins des personnes en situation de handicap
 - Le renforcement de la formation de base et la formation continue.
 - Le renforcement du cadre réglementaire et partenariat.
 - La mobilisation sociale et lutte contre la stigmatisation.
 - Le suivi-évaluation et recherche.
- **Q) selon le décret de la carte sanitaire, le secrétariat de la commission nationale de l'offre de soins est assurée par:** la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires. Elle est présidée par le Ministre de la Santé ou, en cas d'empêchement de ce dernier ,par le secrétaire général du ministère de la santé.

- **Q) parmi les services d'information et d'orientation aux citoyens:(programme khadamti) lancé en janvier 2016 :**

- Allo ville épidémiologique
- Allo intoxication
- Sihati
- Allo SAMU 141
- Santé des jeunes
- Allo rendez vous (maw3idi)
- Allo chikaya

- **Q) le dépistage sélectif du diabète dans les établissement de soins de santé primaires se fait au profil de:**

- Les personnes en surpoids ou obèses avec ou sans HTA
- Femmes avec ATCD de diabète gestationnel
- Femmes ayant accouchées d'un enfant avec un poids de naissance élevé (4KG)
- Personnes ayant des ATCD familiaux de DID
- Personnes avec dyslipidémie
- Personnes âgées de plus de 45 ans

- **la cause la plus fréquente de la pleurésie est :** est la tuberculose

- **Q) dans le PLAT la définition de cas se classe selon:**

- Le site anatomique
- La résistance aux médicaments
- La statut par rapport au VIH
- ATCD de TTT anti bacillaire

- **Q) le réseau hospitalier est composé des établissements suivants:**

- Les hôpitaux préfectoraux et provinciaux
- Les HR
- Les formations hospitalières relevant des centres hospitaliers érigés en établissements publics
- Les hôpitaux psychiatriques
- Les centres régionaux d'oncologie
- Les centres d'hémodialyse

- **Q) les paramètres utilisés pour évaluer un programme de santé:**

- indicateur de performance
- indicateur d'impact

- **les critères de Jones :** élément de diagnostic de RAA

- **Q) le réseau hospitalier est appuyé par:**
 - Le centre national et les centres régionaux de transfusion sanguine et d'hématologie
 - Les laboratoires de l'INH
 - Le centre national antipoison et de pharmacovigilance
- **Q) le réseau des ESSP est appuyé par:**
 - Les centres de référence pour la santé reproductive(**CRSR**)
 - Les centres de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires (**CDTMR**)
 - Les laboratoires de diagnostic épidémiologique et d'hygiène du milieu (**LDEHM**)
- **Q) les établissement médico-sociaux:**
 - Destinés à la PEC médicale avec un accompagnement social des personnes à besoins spécifiques
 - Offrent des prestations de soins avec ou sans hébergement
 - Sont créés dans le cadre des SROS soit par le MS, soit en partenariat avec d'autres acteurs publics ou privés

- **Q) le CSR 1 et 2, le CSU 1 et 2 : les centres 4 précédents offrent les prestations préventives curatives et promotionnelles suivantes:**
 - La surveillance épidémiologique
 - Les consultations de médecine générale
 - Les prestations de soins infirmiers
 - Le suivi de la santé de la mère et de l'enfant
 - Le suivi des maladies chroniques
 - Le suivi de la santé des jeunes et des adolescents y compris la santé scolaire
 - Les prestations d'information et d'éducation pour la santé
- **Q) quelque soit l'implantation du CSR 2, il dispense en plus les prestations suivantes:**
 - Les soins obstétricaux d'urgence de base
 - Les analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes et des malades chroniques
 - Les examens d'échographie
- **Q) La carte du RAMED:** permet l'accès à toutes les prestations offertes par les services de l'état à l'exception des interventions de chirurgie plastique et esthétique.

- **Q) quelque soit l'implantation du CSU 2, il dispense en plus les prestations suivantes:**
 - Les soins obstétricaux d'urgence de base
 - Les analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes et des malades chroniques
- **Q) lorsque le CSR 2 est implanté dans le chef lieu d'un cercle administratif qui ne disposant pas de structure hospitalière:** le centre est doté d'un module d'accouchement de 4 à 8 lits et délivre en plus:
 - Des prestations d'urgence médicale de proximité
 - Des soins bucco-dentaires
 - Des consultations de santé mentale
- **Q) lorsque le CSU 2 dans le chef lieu de la commune de rattachement, ne disposant pas de structure hospitalière publique:** il offre en plus:
 - Des prestations d'urgence médicale de proximité
 - Des soins bucco-dentaires
 - Des consultations de santé mentale
- **Une étude épidémiologique de cas témoin:** est une étude analytique

- **Q) les fonctions de la santé publique:** sont au nombre de 8:

- ❖ 4 essentielles:

- 1) Surveillance et évaluation des indicateurs sanitaires
- 2) Préparation et riposte de santé publique aux flambées de maladies, catastrophes naturelles et autres situations d'urgence
- 3) Protection de la santé, y compris la gestion de la salubrité de l'environnement, de la sécurité sanitaire des aliments, de la sécurité toxicologique et au travail
- 4) Promotion de la santé et prévention des maladies par des interventions en milieu communautaire, y compris par une action pour s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé et aux inégalité en matière de la santé

- ❖ 4 d'appuis:

- 1) Garantir l'efficacité en matière de gouvernance de la santé, une législation de santé publique, un financement et un soutien institutionnel
- 2) Garantir un personnel suffisant et compétent pour des prestations efficaces en matière de santé publique
- 3) Communication et mobilisation sociale pour la santé
- 4) Faire avancer la recherche en santé publique pour avoir une influence sur les politiques et les pratiques

- **Q) en santé publique:** on évalue:
 - La pertinence de l'action
 - L'impact de l'action
 - La cohérence de l'action
- **Q) Orientations et interventions stratégiques pour le renforcement de la santé publique au Maroc:**
 - 1) Obtention d'un niveau plus élevé d'engagement en faveur de la santé publique au Maroc
 - 2) Élaboration d'un système de surveillance intégrée des maladies (et des facteurs de risque)
 - 3) Promotion des comportements favorables à la santé à travers le principe de la santé dans toutes les politiques
 - 4) Renforcement des capacités de la santé publique en termes de ressources humaines
- **Q) selon la loi 34-09 sur le système de santé et l'offre de soins, le droit à la protection de la santé est une:** responsabilité de l'état et de la société

- **Q) la détermination des besoins en santé est basée sur les approches suivantes:**

www.ispits.net

- La méthode des besoins normatifs
- La méthode des objectifs de prestations
- L'efficacité de l'action
- L'efficience de l'action

- **Q) le livre blanc pour une nouvelle gouvernance du secteur de la santé:**

Pourquoi faut-il une nouvelle réforme du système de santé au Maroc?

1. Le Maroc change
2. Des besoins nouveaux
3. Un système de soins qui n'est plus adapté à ce nouveau contexte
4. La nouvelle donne: la constitution 2011

Il identifié 3 axes et 9 chantiers:

- ❑ Axe 1: agir sur les déterminants de la santé, promouvoir ce qui peut améliorer et protéger les populations contre ce qui menace leur santé:

Chantier 1: développer les fonctions essentielles de santé publiques

Chantier 2: mettre la santé au cœur des politiques publiques

Chantier 3: l'action locale sur les déterminants de la santé

❑ Axe 2: vers la couverture universelle: proximité, qualité, protection financière:

Chantier 4: une politique de proximité et d'accès

Chantier 5: réguler la qualité des soins et protéger les utilisateurs

Chantier 6: réduire la part des paiements directs pour les soins, étendre la couverture des mécanismes de solidarité.

❑ Axe 3: moderniser la gouvernance de santé:

Chantier 7: mettre en places les structures et les capacités que la modernisation de la gouvernance impose et contractualiser la complémentarité public-privé

Chantier 8: un système d'information intelligent

Chantier 9: un atout qui est aussi un défi: les professionnels de santé et la réforme.

• **Q) Les missions d'un hôpital universitaire sont :**

- Les soins.
- La recherche.
- La formation.
- La restauration.
- L'hôtellerie

- **Q) selon la porté de la démarche la planification est:**

- Tactique
- Opérationnelle

- **Q) Le cycle de la planification sanitaire comprend les étapes suivantes:**

Étape 1: la recherche d'un consensus sur les buts ou finalités

- Identification des problèmes
 - Établissement des priorités
 - et analyse de la situation
 - Fixation des buts
- } p. normative et stratégique

Étape 2: définition d'objectifs spécifiques prioritaires

- Fixation des objectifs généraux et spécifiques
 - Détermination des actions pour atteindre les objectifs
 - Prévision des ressources requises
- } p. Tactique structurelle

Étape 3: programmation des moyens et des activités

- Fixation des objectifs opérationnels
 - Mise en œuvre du programme
 - évaluation
- } p. opérationnelle

- **Q) Les caractéristiques de la planification:**
 - Créativité
 - Processus dynamique et continue
 - Obéit aux orientations stratégiques
- **Q) Les CHU sont:** des établissements de recours interrégional ou national
- **Q) le taux de mortalité infantile en 2011 (pour mille naissance):**
 - En milieu rural: 33,5
 - En milieu urbain: 23,6

} 28,8
- **Q) l'indice synthétique de fécondation au Maroc en 2015:**
 - En milieu rural: 2,49
 - En milieu urbain: 1,99

} 2,19
- **Q) la capacité litière des hôpitaux publics au Maroc en 2015:** 22075 lits
- **Q) les services extérieurs du MS:**
 - Directions régionales
 - Délégations

- **Q) la surveillance de la grossesse consiste à:**
 - Faire 4 consultations prénatales
 - Faire au moins une échographie
 - Faire un bilan biologiques pour toutes les femmes enceintes
- **Q) les objectifs de la 1ère CPON:**
 - Examiner le périnée
 - Promouvoir la mise au sein précoce
- **Q) la désinfection de haut niveau:** est utilisé pour stérilisé le matériel endoscopique
- **Q) l'hypochlorite de sodium à 5 %:** est utilisé pour décontaminé le matériel souillé
- **Q) La prévalence de l'HTA:** 80%
- **Q) les suites de couche précoces:** est la période qui s'étale: du 2ème au 8ème jour après l'accouchement.
- **Q) le taux de létalité :** C'est le nombre de décès par maladie **M**, rapporté à la population ayant attrapé la maladie **M** pendant la période **t**.

- **Q) les paramètres à surveiller chez les parturientes mises sous sulfate de magnésium:** les reflexes rotuliens, la fréquence respiratoire et la diurèse.
- **Q) les signes qui orientent le diagnostic vers un choc septique (patient opéré depuis 4j) :**
 - Tachycardie
 - Marbrures
 - Hyperthermie supérieur à 40°C
 - Hypotension
 - Frissons
- **Q) le respect du droit du patient en particulier de la personne âgée, amène le soignant à:**
 - Respecter le droit de disposition de la personne (autonomie...)
 - Respecter le droit de la protection (information, consentement...)
 - Faire les soins adaptés à la personne et auxquels elle a droit.
- **Q) les pôles de gestion d'un centre hospitalier:**
 - Le pole des affaires administratives
 - Le pole des affaires médicales
 - Le pole des soins infirmiers

- **Q) le pancréas :** glande mixte qui est a 2 fonctions:
 - **F. exocrine:** permet de synthétiser les enzymes pancréatiques utiles au système digestif et les déverser dans le duodénum comme l'amylase, lipase..
 - **F. endocrine:** assurée par les ilots de langerhans du pancréas: cellules- α synthétisent le glucagon et les cellules- β synthétisent l'insuline; et la somatostatine les 3 hormones de régulation de la glycémie.
- **Q) Les réseaux d'organisation de l'offre de soins en mode fixe:** sont 4:
 - a. RESSP
 - b. RH
 - c. RISUM
 - d. REMS
 - e. Comprend en outre: des structures spécialisées d'appui, installations de santé mobile, des équipements biomédicaux lourds, des installations de haute technologie
 - f. Ces établissement peuvent dispenser outre les prestations rendues en mode fixes d'autres prestations en mode mobile pour répondre aux besoins des populations au moyen de: VAD, UMM, CMS, HM ces prestations peuvent rendues par le secteur privé
- **Q) le ratio médecin/infirmier préconisé par l'OMS :** un médecin pour 2 infirmiers.

- **Q) l'espérance au vie à la naissance au Maroc:** est de 75,8 (santé en chiffres)
- **Q) le TOM des hôpitaux:** est de 63,8 % (santé en chiffres)
- **Q) la DMS au:** est de 4j
- **Q) les résultats attendus du plan national de prévention et du contrôle du cancer dans le domaine de prévention:** est de
 - réduire de 30% la prévalence des risques comportementaux et environnementaux.
 - Guérir 50% des patients pris en charge
- **Q) la stratégie du plan national de prévention et du contrôle du cancer repose sur les domaines suivantes:**
 - Prévention
 - Détection précoce
 - PEC diagnostique et thérapeutique
 - Soins palliatifs
- **Q) Le vaccin antirabique consiste à:** une injection à J0, J7, J21
- **l'antagoniste de l'héparine:** est les sulfates de protamine ou polybrene

- **Q) le nombre des ESSP au Maroc:** est de 2792 (santé en chiffres 2015)
- **Q) le nombre du EH au Maroc:** est de 155 (santé en chiffres 2015) Le nombre d'hôpitaux publics est passé de 52 en 1960 à 142 en 2011 dont 40 sont des hôpitaux spécialisés et 102 sont généraux
- **Q) le nombre d'habitants par ESSP:** est de 12266 H (santé en chiffres)
- **Q) le nombre d'habitant par médecin:** 1925 (tt spécialité P/P)
- **Q) les maladies non transmissibles:** représentent 56% de la charge de morbidité générale
- **Q) le cerveau de l'enfant:** atteint à 6 ans 90% de sa taille adulte
- **Q) la poussée dentaire d'un enfant de 24 mois est de :** 8 incisives, 4 canines, 4 prémolaires
- **Q) le Ptyalisme:** une sécrétion salivaire exagérée
- **Q) Le ténesme:** est la sensation de présence d'un corps étranger intra rectal ou une évacuation incomplète après la selle.
- **Q) Le cornage:** est une respiration sifflante, c'est un sifflement laryngo-trachéal
- **Q) la papule:** une petite élévure de la surface de peau de la grosseur d'une lentille

- **Q) La vaccination Rota s'agit-il, de? :**
- ❖ Retarix : 2 doses aux âges de 2 et 3 mois
- ❖ RetaTeq : 3 doses aux âges de 2, 3 et 4 mois
- **Q) les Nouures:** Sont des tuméfactions dures, arrondies, douloureuses, siégeant sur la surface d'extension des membres.
- **Q) pour lever les barrières d'utilisation des services de soins les gouvernements préconisent :**
 - Améliorer l'accès aux soins
 - Améliorer la gouvernance
 - Améliorer la qualité de la PEC
- **Q) En tant que cadre impliqué dans le processus de régionalisation, la déconcentration signifie :**
 - Délégation de signature, de pouvoirs ou d'attributions du pouvoir central vers les représentants de l'Etat dans un souci d'efficacité et de proximité
 - Pouvoir hiérarchique dont l'objectif ultime est le rapprochement de l'administration des citoyens
- **Q)La population couverte par une assurance maladie:** 40% en 2013 (34% en 2010)

www.ispits.net

- **Q) L'amélioration du financement et de la gouvernance du système de santé régional suppose :**
 - Renforcement de la régionalisation, de la déconcentration et de la contractualisation
 - L'Adoption et l'implantation des nouveaux outils de planification et de gestion
 - Développement des actions de coordination sectorielle entre les structures ambulatoires et hospitalières
 - Augmentation des recettes propres des hôpitaux/application de l'AMO et du RAMED
- **Q) les OMD sont caractérisé par:**
 - L'année de base pour mesurer les progrès est l'année 1990
 - 193 états membres de l'ONU et 23 organisations internationales l'ont adoptés en 2000, qui ont convenu de les atteindre pour 2015.
- **Q) Dans le processus de planification sanitaire, les objectifs spécifiques :**
 - Définissent les résultats de l'évaluation d'une action sanitaire
 - Ont une liaison avec les indicateurs sanitaires
 - Servent de points de référence pour la prise de décisions

- **Q) les principaux indicateurs de la santé des jeunes et adolescents sont:**
 - Maladies de l'enfant et son traitement
 - Travail de l'enfant
- **Q) Le programme élargi de la vaccination mis en place en 1980 et réorganisé en « programme national d'immunisation » en 1987 a connu plusieurs ajustements qui ont été marqués par:** l'introduction en 2011 de 3 nouveaux antigènes : antirotavirus + anti pneumocoque + anti-HIB
- **Q) L'amélioration de la qualité de la PEC en santé maternelle consiste spécifiquement à:**
 - Améliorer les conditions de travail du personnel
 - Disposer d'un personnel qualifié
 - Offrir des services 24/24 heures
 - Etablir des protocoles nationaux de PEC des complications obstétricales
- **Q) selon la stratégie sectorielle 2012-2016, le développement de la santé en milieu rural repose sur les actions suivantes:**
 - Renforcement de la stratégie de couverture sanitaire fixe
 - Renforcement de la couverture sanitaire mobile
 - Développement de la participation communautaire.

- **Q) la morbidité au Maroc a évolué autour de 3 tendances (stratégie de coopération Maroc-OMS 2017-2021):**
 - a) La maîtrise voire l'élimination d'un certain nombre de maladies: le paludisme, la schistosomiase, la lèpre, le trachome, et les maladies cibles de la vaccination
 - b) La persistance de maladies qui continuent d'être des problèmes de santé publique: la tuberculose, le VIH/ sida, les hépatites, les leishmanioses, les méningites, les toxi-infections alimentaires collectives et certaines zoonoses
 - c) L'accroissement des maladies chroniques: dont les plus fréquentes sont les maladies cardio-vasculaires, le diabète, les cancers, et les affections respiratoires chroniques, des troubles psychologiques et psychiatriques et des maladies émergentes réémergentes, notamment les urgences de santé publique de portée internationale.
- **Q) la couverture médicale universelle:** consiste à:
 - Améliorer la qualité et la gamme des soins
 - Réduire les paiements directs
- **Q) le nourrisson:**
 - Triple son poids à 1an
 - Son gain statural durant la première année est de 22 à 24 cm.

- **Q) Les composantes de l'évaluation des services de santé comprennent:**
 - le rendement du personnel et la présence du personnel
 - la qualité des prestations fournies
 - La disponibilité du matériel
 - Le nombre des prestations réalisées
- **Q) les paramètres utilisés pour évaluer un programme de santé:**
 - indicateur de performance
 - indicateur d'impact
- **Q) les déterminants de la santé font intervenir les éléments suivants:**
 - Infrastructures sanitaires
 - Environnement économique
 - Le mode de vie de l'individu
- **Q) les programmes définis dans la stratégie nationale en santé mentale:**
 - Le programme de santé mentale de l'enfant et de l'adolescent
 - Le programme de lutte contre la toxicomanie
- **Q) Les éléments essentiels pour l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre des activités sanitaires sont :** la vision, les stratégies, les ressources, et les critères de performance ou d'évaluation.

- **Q)les scénarios possibles dans le rapport coût-qualité:**
 - Améliorer la qualité par l'augmentation des coûts
 - Améliorer la qualité à coût constant
 - Diminuer les coût et augmenter la qualité
 - Réduire les coût à qualité constante
- **Q) les normes et critères de l'évaluation des prestations de soins en rapport avec la PEC du patient:**
 - La répartition quotidienne du personnel est équitable selon la charge de travail
 - La programmation des soins est révisée régulièrement selon la prescription médicale
 - L'approvisionnement en médicaments urgents est assuré en dehors des heures ouvrables de la pharmacie.
- **Q)La Couverture vaccinale (en %) des enfants âgés de 12-23 mois pour l'ensemble des vaccins a atteint en 2011:** 87,7% (93,5% MU et 82,6 MR) (BCG = 98,5%; DTCOQ/POLIO= 95,2%; VAR= 89,3%) (santé en chiffres) et hépatite b plus de 98%

- **Q) la mise en place d'un programme de santé est la phase la plus importante du processus de planification sanitaire:**
 - Car il est l'aboutissement des décisions prises
 - Son succès dépend des facteurs de la qualité de communication avec le personnel de santé
 - La sous estimation d'une action peut mettre en péril le programme.
 - La motivation du personnel constitue la première étape
- **Q) les maladies à caractère sociale:** tuberculose pulmonaire, paludisme, syphilis primaire et secondaire.
- **Q) Les maladies quaranténaires:** peste, choléra, fièvre jaune, typhus épidémique à poux et lièvre récurrente à poux.
- **Q) l'évaluation des prestations de santé:**
 - Permet l'appréciation du degré de réalisation des objectifs sanitaires
 - Repose sur des critères fondés sur les normes
- **Q) le PIB est:**
 - Un indicateur approximatif de la richesse créée sur un territoire
 - Basé sur le principe de territorialité.

- **Q) la densité litière publique en 2015:** est d'un lit pour 1 551 habitants
- **Q) les maladies infectieuses et contagieuses à déclaration obligatoires: (sur le plans national et international):**
 1. **Maladies infectieuses intestinales:** choléra, fièvre typhoïde et paratyphoïde, autres salmonelles, toxi-infection alimentaires, amibiases.
 2. **Tuberculoses:** primo infection, tuberculose pulmonaire, autre tuberculose de l'appareil respiratoire, tuberculose des méninges et des SNC, tuberculose de l'intestin, du péritoine, et des ganglions, tuberculose miliaire
 3. **Antropozoonoses bactériennes:** la peste, le charbon, la brucellose
 4. **Autres maladies bactériennes:** la diphtérie, la coqueluche, la lèpre, infection à méningocoque, le tétanos.
 5. **Maladies à virus:** poliomyélite, variole, rougeole, rubéole, fièvre jaune, hépatite virale, rage, trachome.
 6. **Rickettsioses et autres maladies infectieuses :** typhus exanthématique, paludisme, leishmaniose, fièvre récurrente.
 7. **Maladies vénériennes:** syphilis congénitale, syphilis symptomatique récente, syphilis cardio-vasculaire récente, infections gonococciques.

- **Q) les maladies à déclarations obligatoires:**
 - ❖ Les maladies soumises au règlement sanitaire international:
 - La peste
 - La fièvre jaune
 - Le choléra
 - ❖ Maladies pouvant donner lieu à des poussées épidémiologiques:
 - La diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et les paralysies flasques aiguës, la rougeole, la tuberculose, le paludisme, la bilharziose, la lèpre, le sida, les urétrites masculines gonococciques et non gonococciques, la syphilis primo-secondaire, les infections méningococciques, la fièvre typhoïde et paratyphoïde, les toxi-infections alimentaires collectives, la rage humaine, le trachome.
 - ❖ Autres maladies à déclarations obligatoires:
 - Le RAA, les leishmanioses, le charbon humain, la brucellose, les hépatites virales, la leptospirose, le typhus exanthématique, la fièvre récurrente, la conjonctivite gonococcique du nouveau-né.
 - ❖ Les maladies donnant lieu à désinfection obligatoire:
 - La peste, le choléra, les fièvres typhoïde et paratyphoïdes, la tuberculose, la poliomyélite, la leptospirose

❖ les maladies donnant lieu à désinsectisation obligatoire:

- La peste, la fièvre jaune, le choléra, les leishmanioses, les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes, le typhus exanthématique.

❖ Les maladies donnant lieu à dératisation:

- La peste, la leptospirose, les rickettsioses

• **Q) la dépense totale de santé en 2013 est financée par:**

- Le paiement direct des ménages : 50,7% (53,6 en 2010 et 57, 3 en 2006)
 - Les ressources fiscales : 24,4%
 - La couverture médicale : 22,4%
 - Les employeurs : 1,2%
 - La coopération internationale : 0,6%
 - Les autres sources : 0,7%
- ## • **Critère de l'OMS:**
- 1 medecin pour 2 infirmier
 - un infirmier pour 5000 h
 - une sf pour 5000 h
 - un medecin pour 10000

- **Q) les facteurs influençant le système de santé:**
 - les facteurs démographiques
 - Les facteurs culturels
 - Les facteurs liés au système de financement
- **Q)la méthodologie d'évaluation d'une prestation répond au processus chronologique suivant:** Le recueil des données, la description de la pratique idéale, l'analyse des données, la corrections des écarts
- **Q) l'ordre décroissant des taux d'incidence des maladies cibles de la vaccination au Maroc:** tuberculose, rougeole, coqueluche, tétanos.
- **Q) la consommation médicale est composée:** des soins hospitaliers et ambulatoires et des biens médicaux
- **Q)Quelque soit l'organisme gestionnaire, le régime d'assurance maladie obligatoire de base couvre:**
 - Le (les) conjoint (s) de l'assuré
 - Leurs enfants handicapés à charge, sans limite d'âge
- **Q)la gestion du patient:** doit être centrée sur la personne et non sur la tâche

- **Q) le panier de soins du RH**
 - CHP: 20 spécialités
 - CHR: 28 spécialités
 - CHI: 40 spécialités
 - Les hôpitaux de proximité HP: 5 spécialités
- **Q) la 1^{ère} cause de mortalité au Maroc:** représentée par les maladies cardiovasculaires.
- **Q) le taux de décès maternel pour (100000 NV) :** est de 72,6 pour 100000 naissances (44,6 en MU 111,1 en MR) soit une réduction en milieu urbain de 39% et en milieu rural de 25%. (santé en chiffres 2015-2016)
- **Q) Les fonctions des soins d'urgence médicale sont:** au nombre de 16f
- **Q) les principaux axes du plan national pour la prise en charge des urgences médicales sont: (2012-2016)**
 - La réorganisation et la restructuration de la prise en charge des urgences médicales hospitalières
 - Le renforcement du partenariat public-privé et public-public
- **Q) La grille de compétence du personnel de l'unité** est un outil nécessaire à l'identification des besoins en formation:

- **Q) Parmi les propositions ayant trait aux mesures d'accompagnement de l'optimisation, la régulation et la maîtrise des dépenses de santé pour assurer la pérennité et la viabilité financière de l'AMO:**
 - L'adoption d'une liste des médicaments admis au remboursement
 - L'adoption d'une liste des ALD fixée par arrêté du MS
 - l'organisation par les organismes gestionnaires de l'AMO de services chargés du contrôle médical
 - La conclusion de conventions de tarification avec les prestataires de soins publics et privés
- **Q) Les études coût-efficacité :** relie les coûts d'une action médicale à ses conséquences exprimées en unités physiques tel que les années de vies sauvées, le nombre de malades évités
- **Q) Le responsable de l'unité de soins:** assure le contact avec le corps de métier lors d'un problème technique urgent:
- **Q) Dans le cadre de l'AMO et en cas de maladie grave ou invalidante nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux:** la part restant à la charge de l'assuré ne peut être supérieure à : 10% de la TNR

- **Q) La répartition des patients:** tient compte de leurs besoins et du niveau d'habileté du personnel
- **Q) La disponibilité du personnel soignant** est assurée au moment des heures des visites des familles:
- **Q) les objectifs de maintien du niveau de compétence du personnel:** fait partie des objectifs de l'unité
- **Q) l'isolement septique:** est indiqué lorsque le patient est atteint d'une infection naturellement contagieuse.
- **Q) Le dossier infirmier** est un support écrit pour faciliter la communication verbale lors des changements des équipes.
- **Q) L'éthique du soin:** est un processus décisionnel fiable et vérifiable basé sur des règles et principes universels
- **Q) Les exceptions du respect de la confidentialité:** sont liées à des atteintes potentielles à la sécurité publique
- **Q) le leadership:** la capacité d'influencer les autres pour atteindre un but commun
- **les maladies nécessitant une association vaccination+sérothérapie:**
 - la rage
 - tétanos
 - hépatite virale B

www.ispits.net

- **Q) les temps de la planification stratégique sont:**
 - Le temps politique
 - Le temps stratégique
 - Le temps tactique
- **Q) les outils de la planification stratégique:**
 - Le budget programme
 - CS
 - SROS
 - PEH
 - Plan d'effectif
 - Normalisation des critères d'allocation des ressources
 - Le plan stratégique régional
- **Q) dans le programme du gouvernement 2012-2016, le secteur de la santé se trouve interpellé de façon directe à travers l'axe réservé à:** la garantie de l'accès aux soins.
- **dans le cop 22:** déclaration d'éradication du trachome au maroc
- **le MS:** a obtenu récemment le prix e-mti az pour mawaidi (prise de RDV), comme il mise annuellement l'opération pour **RIAYA** contrecarrer les effets néfastes des vagues de froid intenses.

- Q) le plan de réorganisation et de développement des urgences médicales au Maroc: comporte 3 objectifs et 10 mesures
- Q) les critères de l'implantation des infrastructures et installations publiques:
 - ❖ Concernant le RESSP:
 - Un CSR 1: pour une population minimale de 7000 habitants
 - Un CSR 2: pour une population minimale de 25000 habitants
 - Un CSU 1: pour une population minimale de 25000 habitants
 - Un CSU 2: pour une population minimale de 50000 habitants
 - ❖ concernant le RH:
 - Hôpital de proximité: exige une population de desserte de 70000 habitants au moins
 - Hôpital P/P: exige en plus du respect du découpage sanitaire une population minimale de 200000 habitants
 - Hôpital interrégional: doit desservir au moins 2 régions sanitaires et couvrir une population de près de 3 Millions d'habitants.

- **Q) la consommation moyenne mensuelle:** est une méthode d'estimation des besoins en produits pharmaceutiques
 - **Q)Selon la stratégie sectorielle 2012-2016:** 4 provinces ne disposent pas en cours des hôpitaux
 - **Q) Les axes de la stratégie sectorielle de santé 2012-2016:**
 - **Axe1:** Amélioration de l'accès aux soins et de l'organisation des services
 - **Axe2:** Renforcement de la santé de la mère et de l'enfant
 - **Axe 3:** Promotion de la santé des populations à besoins spécifiques
 - **Axe4:** Renforcement de la surveillance épidémiologique et développement des vigilances sanitaires
 - **Axe5:** Développement du contrôle des maladies non transmissibles
 - **Axe6:** Développement et maîtrise des ressources stratégiques de la santé
 - **Axe 7 :** Amélioration de la gouvernance du système de santé
- ➔ **ces 7 axes seront déclinés en 28 plans d'actions spécifiques, totalisant 168 actions.**

- **Q) le budget intérieur du MS:** représente 2,8% du budget intérieur de l'état
- **Q) les dépenses du MS :** représente 1,3% du PIB
- **Q) budget du MS:** représente 5,3 du budget général de l'état
- **Q) la part des dépenses totales en santé dans le PIB:** 5,8 en 2013 (6,2 en 2010)
- **Q) les dépenses globales de santé en 2013:** est de 52 milliards de DH.
- **Q) les paiements directs des ménages pour la santé en 2013:** est de 50,7%
- **Q) Le taux d'infection nosocomiale:** est un indicateur de qualité de fonction de soin (La fonction hôtellerie ??? ; La fonction gestion ??)
- **Q) les facteurs de risques reconnus par l'OMS comme responsables des maladies chroniques mortelles et handicapantes sont:**
 - La consommation du tabac
 - L'usage nocif de l'alcool
 - L'alimentation malsaine
 - Le manque d'activité physique et la sédentarité
- **L'organisation des conférences de santé au maroc:**
 - 1^{ER} conférence en 1959
 - 2^{ème} conférence en juillet 2013
- le PN de santé bucco-dentaire: géré par la DELM.

- **Q) les 3 étapes essentielles d'élaboration des SROS sont:**
 - 1) L'identification des problèmes et la fixation des grandes orientations
 - 2) La mobilisation des ressources
 - 3) La détermination des mesures à prendre
- **Q) le plan stratégique régional:** est un document d'orientation des actions sanitaires de la région, il comprend:
 - Une étape d'analyse de la situation
 - Une étape de formulation stratégique
- **Q) le plan régional de couverture sanitaire a pour objectif de:**
 - La répartition géographique des ressources humaines
 - Les liaisons, la coopération et la complémentarité entre les établissements de santé et entre les secteurs
- **Q) parmi les objectifs du plan d'action 2012-2106:**
 - Réduire la mortalité maternelle de 112 à 50 décès pour 100000 naissances vivantes
 - Réduire la mortalité néonatale de 19 à 12 pour 1000 naissances vivantes

- **Q) les types d'analyse du diagnostic hospitalier:**
 - Une analyse de morbidité hospitalière
 - Une analyse stratégique
 - Une analyse de la performance
- **Q) les 2 logique sur lesquels repose la formation du projet d'établissement:**
 - Une logique de projet
 - Une logique professionnelle? (je suis pas sur à 100%)
- **Q) parmi les approches de résolutions des problèmes pour l'amélioration de la qualité:**
 - Résolution individuelle des problèmes
 - Résolutions systématique de problème en équipe
 - Amélioration des processus.
- **Q) le comité de gestion d'un CHR est présidé par:** le délégué du ministère de la santé de la province ou préfecture chef lieu de la région.
- **Q) l'admission ordinaire dans un hôpital public:** peut se faire seulement pendant les jours et les heures ouvrables.

- **Q) la prévalence des:**
 - troubles dépressifs: est de 26,5%
 - Troubles d'anxiété généralisée : est de 9%
 - Troubles psychotiques: 5,6%
- (Source: l'enquête nationale des troubles mentaux et toxicomanies)
- **Q) les objectifs du plan national de santé mentale:**
 - Promouvoir la santé mentale et prévenir les troubles mentaux, ainsi que les conséquences individuelles et sociales
 - L'amélioration de l'accessibilité de de la qualité de la PEC des malades mentaux
 - La lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes souffrant des troubles mentaux.
- **Q) les maladies à déclaration obligatoire en vertu du règlement sanitaire international 2005**
 - la polio à virus sauvage
 - La variole
- **Q) la certification:** est une attestation de conformité aux exigences spécifiques.

- **Q) les hôpitaux ayant bénéfice du lancement de réhabilitation des pôles des urgences médicales:**

- Hôpital El Farabi à Oujda,
- Hôpital Ibn Toufail à Marrakech,
- Hôpital Ibn Rochd à Casablanca
- Hôpital de Sidi Bennour.

- **Q) les attributions du ministère de la sante:**

- Elaboration et mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de santé de la population
- Agit, en liaison avec les départements concernés, en vue de promouvoir le bien-être physique, mentale et social des habitants
- Harmonise les orientations et coordonne les objectifs et les actions ou mesures qui concourent à l'élévation du niveau de santé dans le pays et intervient afin d'assurer, au niveau national, une meilleure allocation des ressources, en matière de prévention, de soins curatifs ou l'assistance
- Elaboration et mise en œuvre de la politique nationale en matière de médicaments et de produits pharmaceutiques sur les plans technique et réglementaire

- Assure le suivi de la politique sanitaire internationale à laquelle le Maroc contribue, définit en concertation avec les départements concernés, les options de coopération dans le domaine de la santé, assure la mise en application et le suivi de réalisation des programmes convenus.
- Assure le contrôle de l'exercice des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
- **Q) Les actions en rapport avec la réforme administrative du secteur de la santé visant l'instauration de la confiance des citoyens :**
 - La facilitation des procédures administratives et de l'accès aux services
 - Le respect du droit à l'information
 - La mise en place d'unités administratives d'accueil et de communication
 - Le renforcement de l'administration électronique
 - La mise en place de systèmes de gestion des plaintes et de gestion des RDV
- **Q) Maroc s'est engagé à réduire, à l'horizon 2015, de trois quarts la mortalité maternelle (OMD5) pour les faire passer respectivement de : 332 à 83 décès pour cent mille naissances vivantes,**

- **Q) les départements ministériels impliqués dans la santé scolaire et universitaire :**
 - ministère de la santé.
 - ministère d'éducation nationale et de la formation professionnelle.
 - ministère de la jeunesse et des sports.
 - ministère d'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de formation des cadres.
 - ministère de l'intérieur.
- **Q) le projet d'établissement hospitalier comprend les projets suivants:**
 - Le projet médical
 - Le projet de soins
 - Le projet managérial
 - Le projet d'investissement et de maintenance
 - Le projet du système d'information
 - Le projet social
- **la performance d'un SS:** dépend de la connaissance, des compétences, de la motivation, et de la distribution du personnel chargé d'organiser et de fournir des prestations.

- **Q) Les établissements de santé sont organisés et gérés en vue de respecter :**

www.ispits.net

- droits fondamentaux de la personne humaine
- normes de sécurité des patients
- normes de sécurité des installations, des équipements et les personnes qui y travaillent
- règles d'éthique et de déontologie applicables à chaque profession ;
- normes et standards de qualité
- règles d'hygiène et de salubrité
- règles de bonne pratique clinique.

- **Q)les principes sur lesquels repose le système de santé marocain sont :**

- la solidarité et la responsabilisation de la population dans la prévention, la conservation et la restauration de la santé;
- l'égalité d'accès aux soins et services de santé;
- l'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires ;
- la complémentarité intersectorielle;
- l'adoption de l'approche genre en matière de services de santé.

- **Les hôpitaux universitaire ont :**
 - une mission de soin de diagnostic et formation
 - un caractère national
 - un statut particulier
 - un conseil d'administration
- **Q) Les établissements de santé sont organisés et gérés en vue de respecter:**
 - les normes de sécurité des patients
 - les droits fondamentaux des patients
 - les règles de bonnes pratiques cliniques
- **Q) La charge de morbidité globale au Maroc est constituée par les groupes d'affections suivantes : (SS 2012-2016):**
 - a. Affections infectieuses, maternelles et périnatales: 33,4%
 - b. Maladies non transmissibles avec: (55,8%)
 - c. Traumatismes avec: 10,8%
- **les 3 cancers les plus fréquents au maroc:** cancer du col utérin, du sein, et du poumon.
- **pour atteindre les ODD 2030:** les pays membres doivent disposer d'une proportion de 4,45 en 2030, actuellement au maroc elle est de pris de 2,60
- **L'offre de dépistage des personnes porteuses de VIH au maroc** vise que 90% puissent le savoir d'ici 2021.

- **Q) La lutte contre la mortalité néonatale suppose :**
 - ❖ **Mise à niveau des structures d'accouchement:**
 - Reconstruction et réaménagement des structures d'accouchement
 - le renforcement des équipements des structures d'accouchement
 - ❖ **Organiser et renforcer l'offre des soins en néonatalogie:**
 - la définition des filières de soins en néonatalogie
 - Mise à niveau de 09 structures de néonatalogies ;
 - Veille à la disponibilité de l'équipement requis par niveau de prise en charge néonatale
 - Création pour chaque région une unité de soins intensifs en néonatalogie
 - Assurer la garde résidentielle des pédiatres au niveau des unités régionales de néonatalogie
 - Assurer la disponibilité des médicaments essentiels au niveau de toutes les unités de néonatalogie et de toutes les structures d'accouchement.
 - ❖ **Renforcement de la surveillance néonatale pendant le post-partum:**
 - la documentation de l'état de santé de tout nouveau-né sur le carnet de santé de l'enfant
 - Médicalisation de l'examen initial de réception (l'examen à la naissance) de tout nouveau-né ainsi que celui avant sa sortie des structures d'accouchement .

❖ Amélioration de la qualité de prise en charge des nouveau-nés

- Renforcement des structures d'accouchement des hôpitaux provinciaux et régionaux en personnels spécialisés et formé en secourisme néonatal
- Mise en place d'un système d'information adapté et assurer le suivi-évaluation du plan d'action
- Instauration d'audit clinique autour des cas de morti-naissance en intra-partum et de mortalité néonatale

❖ Amélioration de la coordination intersectorielle:

- Renforcement de la communication autour du plan d'action ;
- Mobilisation de la participation communautaire autour des objectifs tracés.
- **Q) Les instances de concertation et d'appui dans un hôpital du MS sont:**
 - le conseil des infirmiers et des infirmières
 - le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
 - le comité de suivi et d'évaluation
 - le comité d'établissement
 - le comité de lutte contre les infections nosocomiales
 - Le comité de gestion du centre hospitalier

- **Q) Les nouveaux défis de la santé sont :**
 - La sécurité sanitaire internationale,
 - La prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles,
 - La couverture universelle de santé,
 - La pénurie en ressources humaines de santé,
 - Et la maîtrise des déterminants sociaux de la santé.
- **Q) L'I.R.O.T (l'intervalle de rotation des lits) permet de connaître le nombre de jours où le lit reste vacant entre deux hospitalisations :**
 - Son augmentation traduit une mauvaise utilisation de la C.I.F (capacité litière fonctionnelle)
 - diminution traduit une meilleure utilisation de la C.I.F
- **Q) les Principales causes de mortalité au Maroc en 2014:**
 - Maladies de l'appareil circulatoire: 27,2
 - dont cardiopathie: 18,2
 - Tumeurs: 13,4
 - Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale: 7,9
 - Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: 7,0
- **le nombre de bénéficiaire du ttt antirétroviral (VIH):** est triplé (multiplié par 2,6) entre 2011 et 2016 passant de 4047 à 10645;

- **les structures de l'offre de soins des mutuelles relèvent du:** secteur semi public
- **Q) Les principes de l'AMO:**
 - la mutualité
 - La solidarité
 - Non discrimination: l'équité et l'égalité
- **Q) Les caractéristiques de l'AMO**
 - L'assistance sociale
 - Système obligatoire
 - Système à régime multiple
 - Système contributif
- **Q) Les principes du RAMED:**
 - principes de l'assistance sociale
 - de la solidarité nationale.
 - L'équité
 - L'égalité
- **Q) pandémie:** est une maladie épidémique qui ne connaît pas de frontière.

- **Q) les objectifs du millénaire pour le développement liés directement à la santé:**

- 1) OMD1: Eliminer l'extrême pauvreté et le faim
- 2) OMD2: assurer une éducation primaire pour tous
- 3) OMD3: promouvoir l'égalité des 2 sexes et l'autonomisation des femmes
- 4) OMD4: Réduire la mortalité des enfants de – 5 ans
- 5) OMD5: Améliorer la santé maternelle
- 6) OMD6: Combattre le VIH/ sida, le paludisme et d'autres maladies
- 7) OMD7: assurer un environnement durable
- 8) OMD8: mettre en place un partenariat mondiale pour le développement

www.ispits.net

OMD 4,5 et 6



Sont liés directement à la santé

- **Q) le Maroc s'est engagé à réduire, à l'horizon 2015, de deux tiers la mortalité des enfants de moins de 5 ans (OMD4) pour les faire passer respectivement de : 76 à 25 décès pour mille naissances vivantes**

- **Q) le classement des sources de financement de la santé au Maroc de 1 à 5:**

1. Les ménages (63,3% en 2013: 50,7% PD et 12,6 cotisation salariale à l'AM) (61,9% en 2010)
2. L'état 25,4%
3. L'assurance maladie
4. Les employeurs (hors l'état et les collectivités locales)
5. Les collectivités locales

- **Q) les types de prévention:**

- ❖ **Primaire:** Ce sont tous les actes destinés à diminuer l'incidence d'une maladie dans une population, en réduisant le risque d'apparition des nouveaux cas. Elle est basée sur la vaccination.
- ❖ **Secondaire:** Ce sont tous les actes destinés à diminuer la prévalence des maladies dans une population en réduisant son évolution et sa durée.
- ❖ **Tertiaire:** Ce sont tous les actes destinés à diminuer la prévalence des incapacités chroniques dans une population en réduisant au minimum les invalidités fonctionnelles consécutives à la maladie, et ceci grâce à la réhabilitation et la réinsertion sociale ou fonctionnelle.

- **Q) Une maladie devient une priorité en santé publique aux conditions suivantes :**
 - La prévalence est élevée dans la population
 - Il n'y a pas encore de traitement efficace
 - La maladie est une maladie sévère ou source d'handicap
- **Q) L'épidémiologie est une science qui concerne l'étude :**
 - Des déterminants de l'apparition et de la transmission des maladies
 - De la distribution des maladies
 - Des facteurs de risques d'apparition des maladies
 - Des mesures effectives pour la prévention et le contrôle des maladies
 - des facteurs influant sur la santé et les maladies de la population
- **Q) Le taux de mortalité:** est le nombre de décès annuel rapportés au nombre d'habitants d'un territoire donné.
- **Q) La régionalisation:** c'est le transfère du pouvoir au région selon 2 formes soit la déconcentration (pour les CL) ou bien la centralisation (pour les organismes locaux relevant de l'état).

- **Q) La réforme hospitalière:** vise la préparation des hôpitaux à la transition sanitaire
- **Q) les actions principales définies dans le plan d'action conjoint des départements ministériels concernés par la santé scolaire et universitaire :**
 - Assurer la couverture de 90 % de la population scolaire et universitaire cible par la VMS (2007-08 : 81% en milieu scolaire et 77% en milieu universitaire)
 - Assurer un taux de couverture par le contrôle de l'hygiène en milieu préscolaire et scolaire de 60 % et en milieu universitaire de 100 % (2007-2008 : 49% en milieu préscolaire et scolaire). f
 - Atteindre un taux de couverture pour le dépistage de la malvoyance par l'échelle métrique de 84 % et par la réfraction automatique de 60 % (2007-08 : 76% par EM et 52% par RA). f
 - Promouvoir l'éducation à la santé et le mode de vie sain en milieu scolaire et universitaire.
- **les maladies concernées par les programmes de lutte contre les maladies parasitaires:**
 - A- Le paludisme
 - B- La bilharziose
 - C- La leishmaniose
 - D- Le kyste hydatique
- **le kyste hydatique:** par l'ingestion de produits contaminés par 1 oeufs de parasite existant dans les déchets du chien.

- **Les actions prioritaires définies par le ministère de la santé en matière de santé mentale :**
 - Amélioration de la qualité de la prise en charge des malades souffrant de troubles mentaux par l'extension des structures et programmes de soins
 - Renforcement des ressources humaines, Recrutement, formation et formation continue des intervenants en santé mentale
 - Disponibilité des médicaments psychotropes
 - Amélioration de la qualité de la prise en charge des enfants et adolescents souffrant de troubles mentaux par la création de structures de soins spécifiques
- **Q) La promotion de la santé repose sur :**
 - Une approche médicale
 - Une approche comportementale
 - Une approche sociale et économique
 - Une approche épidémiologique
- **Q) les maladies suivantes sont considérées éliminées du Maroc:**
 - Tétanos néonatale en 2002
 - La poliomyélite 1988

- **Q) les fonctions de l'hôpital:** sont au nombre de 12:
 - ❖ Mission de soins:
 - 1) Diagnostic
 - 2) Traitement
 - 3) Hôtellerie
 - ❖ Mission de développement professionnel:
 - 4) Enseignement
 - 5) Recherche
 - 6) Expertise
 - ❖ Mission de santé publique:
 - 7) Service public
 - 8) Appui au RESSP
 - 9) Assistance
 - ❖ Mission économique et managériale:
 - 10) Achat
 - 11) Gestion des Productions
 - 12) Direction

- **Q) le Maroc assure la couverture de sa consommation en médicaments par la fabrication locale hauteur de: 70%**
- **Q) La capacité litière (secteur P/P):** est de 22075 en 2015
- **Q) le PNI:** cible uniquement les enfants âgés de 0 à 5 ans, et les femmes âgées de 15 ans à 45 ans
- **Q) La mortalité infantile est définie par le rapport suivant:** Nombre de décès d'enfants de moins de 1 an au court d'une période (t) $\times 1000$ / Le nombre d'enfants nés vivants au court de la même période
- **Q) La prophylaxie:** désigne le processus passif ayant pour but d'éradiquer la maladie ou bien l'ensemble des actions entreprises pour éviter l'apparition et la propagation de la maladie et assurer la prévention primaire
- **Q) les Modes et stratégies de couverture sanitaire au Maroc sont:**
 - Fixe
 - Mobile
 - participatif (santé communautaire)
- **Q) En 2016, le taux d'incidence de la tuberculose au Maroc** est de 91 cas pour 100.000 habitants

- **Q) la couverture sanitaire au Maroc par:**
 - ❖ le mode fixe: concerne la population située à une distance de 0 à 3 KM
 - ❖ La VAD: concerne la population située à une distance de 3 à 6 KM
 - ❖ Le point de contact ou l'équipe mobile: concerne la population située à une distance de 6 à 10 KM
 - ❖ Par l'équipe mobile: concerne la population située à une distance supérieur à 10 KM
 - ✓ **Sont couvertes par l'équipe mobile :** Les localités situées à plus de 6 km d'une formation sanitaire et les localités situées à moins de 6 km en cas d'obstacles
- **Q) l'accouchement en milieu surveillé est celui qui survient dans:**
 - Les hôpitaux
 - Les cliniques privées
 - Les maisons d'accouchement
- **Q) Les assureurs et les mutuelles:** représentent des sources de financement du système de santé

- **Q) les Indicateurs de production des hôpitaux publics, année 2015:**
 - Capacité litière: 22 075
 - Nombre d'admissions (*): 1 134 947
 - Nombre de journées d'hospitalisation: 4 816 781
 - Taux d'occupation moyen (TOM) en %: 63,8%
 - Durée moyenne de séjour (DMS) en jours: 4,0 J
 - Taux de rotation (TROT): 51,4
 - Intervalle de rotation (IROT) en Jours: 2,4 J
 - Total des interventions chirurgicales: 318 033
 - Nombre d'interventions chirurgicales par médecin: 166
 - Nombre moyen de consultations spécialisées externes par médecin: 712
 - **La répartition des accouchements ayant lieu dans les services de maternités par type en %:**
 - ✓ Normaux 70,1%
 - ✓ Dystociques 14,7%
 - ✓ Césariens 15,2%

- **Q) les actions du programme gouvernemental dédiées à la santé:**
 - 1) Le renforcement de la confiance dans le système de santé dans un cadre de participation à travers l'organisation d'un forum national sur la santé,
 - 2) L'amélioration de l'accueil,
 - 3) Le renforcement de la disponibilité des médicaments et des services de santé essentiels, particulièrement dans le domaine de la maternité et des urgences;
 - 4) Le renforcement des soins de santé de base surtout en milieu rural,
 - 5) La maîtrise des déterminants sociaux de la santé dans un cadre de collaboration intersectorielle,
 - 6) La consolidation des acquis en matière de lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile en vue d'atteindre les objectifs de 50 pour 100 000 naissances vivantes pour la mortalité maternelle et 20 pour mille naissances vivantes pour la mortalité infant-juvénile.
 - 7) L'encadrement de l'offre de soins à travers la mise en œuvre des dispositions de la carte sanitaire,
 - 8) Le développement du PPP et incitation à la contractualisation avec les médecins privés,
 - 9) Le renforcement de la surveillance épidémiologique et la vigilance sanitaire ainsi que la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles,

- La promotion de la santé des populations à besoins spécifiques;
- La modernisation du réseau des établissements hospitaliers et le renforcement de l'autonomie administrative et financière des hôpitaux régionaux et provinciaux,
- La revalorisation de la médecine générale et la formalisation des filières de soins;
- Et le renforcement de la formation de base des professionnels de la santé.
- **Q) Le système de tiers-payant :**
 - permet à l'assuré de ne pas faire l'avance des frais afférents aux prestations de soins
 - permet à l'assuré de déboursier la part qui reste à sa charge
 - exige des accords entre le prestataire et l'organisme de protection sociale
- **La capacité litière des hôpitaux:**
 - HL: 120_200
 - CHP: 200_500
 - CHR: 500_1000
 - CHU: +1000

<u>L'offre de soins au niveau du HP:</u>	<u>L'offre de soins au niveau du CHP</u>	<u>L'offre de soins au niveau du CHR:</u>	<u>L'offre de soins au niveau CHIR:</u>
➤UMHB ➤Soins intensifs ➤Chirurgie Générale /viscérale ➤Médecine générale ➤L'obstétrique - Seulement ➤Pédiatrie	HP plus: ➤Réanimation polyvalente ➤Gynécologie ➤Anesthésie réanimation ➤Cardiologie ➤Dermatologie-vénérologie-léprologie ➤Gastro-entérologie ➤Néphrologie ➤Ophtalmologie ➤Oto-rhino-laryngologie ➤Pneumo-phtisiologie ➤Réhabilitation ➤Stomatologie ➤Psychiatrie ➤Endocrinologie ➤Traumato-orthopédie	❖<u>CHR</u>: CHP plus: ➤UMHC ➤Chirurgie pédiatrique ➤Médecine interne ➤Neurochirurgie ➤Neurologie ➤Oncologie ➤Rhumatologie ➤Urologie ➤Hématologie	❖<u>CHIR</u>: CHR plus ➤UMHS ➤Réanimation Obstétricale ➤Réa. Néonatale ➤Ch. maxillo-faciale ➤Ch. réparatrice et plastique ➤Mdies. infectieuses ➤Ch. traumatologique ➤Ch. cardio-vasculaire ➤Ch. thoracique ➤Chirurgie vasculaire ➤Chirurgie viscérale

Premier recours ou Niveau de proximité Hôpital local	Deux Niveaux de recours CHP & CHR	Recours interrégional ou référence nationale CHU
Réponse aux besoins essentiels (60 %)	Réponse aux besoins complémentaires (20 %)	•Réponse aux besoins non couverts par niveaux infra •Réponse aux besoins de formation médicale
MCOPU (Décret) –Médecine –Chirurgie –Obstétrique –Pédiatrie –Urgence	•MCOPU + •Recours provincial (Décret) – ORL-Ophtalmo-Stomato- Chir M-F; –GE-Cardio, Pneumo, Nephro, Psy; –Traumato-orth-REA •Recours régional (Décret) : –Chir-ped, Neurochir, uro, chir-plast; –Rhumato, Med-interne, SI.	•MCOPU + •Spécialités de niveau CHR •Spécialités de recours interrégional –Oncologie, –Grefe d’organe, –Ch. Cardiaque, –Grands brûlés, –...
•Paquet Minimum d’équipements	•Mammographie •Scannographie, ...	•IRM , •Gamma-caméra, •Angiographie, •Lithotripsie ...

- **Q) Les missions de la direction régionale sont essentiellement :**
 - mise en œuvre de la politique nationale de santé en tenant compte des spécificités de la région.
 - animation et coordination des actions sanitaires des délégations du MS relevant du ressort territorial de la direction régionale de la santé.
 - promotion des actions de partenariat avec les intervenants dans le domaine de la santé à l'échelle régionale, notamment les collectivités locales, le secteur privé et la société civile. (coordination)
 - La protection de la santé publique et la ville sanitaire
 - La planification stratégique
 - Le financement et la gestion financière
 - La gestion des ressources humaines
 - Le pilotage et la coordination des actions des établissements de santé
- **Q) Au Maroc, les dépenses en santé:** représentent 6,12 en 2016 et 6,17 en 2017
- **Q) la contribution des personnes considérées vulnérables pour bénéficiaire du RAMED est :** 120 DH par personne par an avec un plafond de 600 DH

- **Q) les maladies concernées par le PCIE:**

- Les IRA
- Les diarrhées
- La rougeole
- Mastoïdite
- Angine
- Choléra
- Pneumopathie
- Convulsions
- Déshydratation
- Infection aigue de l'oreille
- Anémie
- Insuffisance pondérale

- **Q) Les signes de la thrombophlébite:** c'est l'association:

- ❖ de signes généraux: une fièvre vers 38° avec le classique pouls grimpant, . une anxiété, un malaise, . une insomnie,
- ❖ et de signes fonctionnels: une douleur, . une simple gêne locale à un membre inférieur

- **Q) Les fonctions d'un SNS: (OMS; 2007):**

- 1) Prestation de services
- 2) Ressources humaines
- 3) Information
- 4) Médicament, vaccin et technologie sanitaire
- 5) Système d'information et métrologie sanitaire
- 6) Financement
- 7) Administration générale/ gouvernance et leadership

- **Q) Le renforcement de la couverture sanitaire mobile implique:**

- La mise en œuvre du plan national des campagnes médicales spécialisées et mobilisation des ressources nécessaires ;
- Renforcement des moyens de mobilité pour la couverture médicale mobile (CMS et EM) ;
- Renforcement du plateau technique des unités mobiles ;
- Mobilisation des ressources nécessaires pour la couverture sanitaire mobile ;
- Renforcement des compétences des prestataires de soins en gestion des unités médicales mobiles

- **Q) Les programmes de prévention et de lutte contre les maladies non permis:** La diminution la mortalité infantile passant de 57 pour mille naissances vivantes en 1991 à 28,8 en 2011
- **Q) En 2011 le taux d'accroissement démographique:** 1,05
- **Q) les axes stratégiques de la vision de santé à l'horizon 2020:**
 - ❖ **Axe 1** : Renforcement des actions de prévention, consolidation des programmes de lutte contre les maladies transmissibles et développement des actions de lutte contre les maladies non transmissibles.
 - ❖ **Axe 2** : Amélioration de l'accès aux soins par la promotion de l'équité dans la répartition des ressources allouées et la réduction des écarts.
 - ❖ **Axe 3** : Résorption du déficit des effectifs du personnel de soins, faire face à la demande croissante et revalorisation du rôle des ressources humaines dans le secteur de la santé.
 - ❖ **Axe 4** : Pérennisation des acquis de la CMB et élargissement du financement du secteur de la santé par le développement de mécanismes collectifs et solidaires de partage du risque maladie.
 - ❖ **Axe 5** : Amélioration de la gouvernance du système de santé.
 - ❖ **Axe 6** : Généralisation de la réforme hospitalière et pérennisation de ses acquis notamment les outils de l'assurance qualité.

❖ Axe 7 : Garantie de l'accessibilité, la disponibilité et la sécurité du médicament et des produits de santé.

❖ Axe 8 : Développement de la recherche en santé.

• **Q) Eléments de la surveillance épidémiologique :**

- Déclarations des décès, www.ispits.net
- Déclaration des maladies,
- déclaration des épidémies,
- Rapports des investigations des épidémies,
- Rapports des enquêtes autour des cas,
- Déclarations et rapports autour des cas
- Etudes épidémiologiques,
- Informations sur la distribution des réservoirs et des vecteurs,
- Informations sur la distribution des médicaments,
- Données démographiques,
- Données environnementales
- Informations publiques et médiatiques.

- **Q) La politique de maintenance de la santé consiste à :**
 - réglementations et coordination du développement du secteur
 - développement de la législation sanitaire
- **Q) Cas sporadique :** C'est l'apparition de cas de la même maladie sans qu'il y ait un lien réel Entre ces cas
- **Q) Types de surveillance épidémiologique:**
 - Passive
 - Active
 - Sentinelle
- **Q) Critères de qualité d'un système de surveillance :**
 - Simplicité
 - Souplesse
 - Acceptabilité
 - Validité: sensibilité, spécificité et valeur prédictive positive (VPP)
 - Représentativité
 - réactivité

- **Q) les grandes axes de l'épidémiologie:**
 - ❖ Selon l'objectif de la recherche:
 - L'épidémiologie descriptive
 - L'épidémiologie analytique:
 - ✓ E.A. d'observation
 - ✓ E.A. expérimentale
 - ❖ Selon le domaine de la recherche: (E. infectieuse, hospitalière, des MNT, clinique, évaluative, environnementale, génétique, séro-épidémiologique...)
- **Q) la classification des études épidémiologiques:**
 - ❖ Selon le temps:
 - Etudes rétrospectives
 - Etudes transversales
 - Etudes prospectives
 - ❖ Selon l'élément de départ de l'étude:
 - Étude de cas ou série de cas
 - Étude de corrélation (étude écologique)
 - étude de cohorte
 - Étude de cas témoins

❖ Selon l'objectif de l'étude

- Les études d'observation:
 - ✓ E.O. descriptives
 - ✓ E.O. analytiques
- les essais cliniques (les études expérimentales)
 - ✓ essais thérapeutiques Ou de prévention secondaire
 - ✓ essais préventifs ou de Prévention primaire
- Les études d'évaluation de l'impact:
 - Q) Une étude épidémiologique de type cas témoin est une étude analytique
 - Q) La prévalence de la cécité au Maroc est de: 0,76%; (obj 2020 prévalence sera 0,3%) et causes: 1 cataracte, 2 glaucome, 3 opacité coronienne
 - Q) la prévalence du glaucome: augmente avec l'age:
 - ✓ entre 2% et 3% à l'age de 40 ans
 - ✓ entre 9% et 10% à l'age de 70 ans
 - Q) Dans le cadre de la gestion de déchets hospitaliers le personnel paramédical d'un hôpital doit: S'assurer que les sacs des déchets sont remplis au $\frac{3}{4}$ au niveau de leurs unités de soins

- **Q) les signes d'hypoglycémie:**
 - palpitations, pâleur, nausées, fatigue intense, transpiration abondante froides faiblesse musculaire, tremblements, malaise vagal, troubles oculaire...
- **Les signes d'hyperglycémie:** de la fatigue et une somnolence, une soif intense; un amaigrissement, un besoin fréquent d'uriner
- **Q) Les indications d'un sondage vésical sont:**
 - rétention,
 - postopératoire,
 - thérapeutique,
 - à titre diagnostique,
 - pour le confort.
- **Q) les contre-indications du sondage vésicale:**
 - 1) le traumatisme de l'urètre,
 - 2) la sténose de l'urètre,
 - 3) la prostatite aiguë,
 - 4) le jeune âge pour un garçon,
 - 5) l'existence d'une prothèse urétrale ou prostatique.

- **Q) l'hémoculture:**
 - ❖ **Objectif ou but:**
 - Confirmer le diagnostic
 - Identifier le germe en cause
 - Réaliser un antibiogramme
 - Mettre le malade sous l'antibiothérapie adaptée. Prescrire l'antibiotique qui agit sur le germe en cause.
 - ❖ **Indication:**
 - Fièvre d'origine indéterminée ; $T^{\circ} > 38.5^{\circ}\text{C}$
 - Hypothermie : température inférieure à 36°C
 - Signe clinique évocateur d'infection : frissons
 - Maladie terminale, chez un immunodéprimé
 - Maladie rapidement fatale
 - Toxicomanie par voie veineuse.
 - Devant un choc septique
 - ❖ **Contre indication:**
 - Bras perfusé
 - Présence d'une fistule artério-veineuse
 - Patient sous traitement antibiotique

- **Q) les complications du décubitus on note:**
 - ❖ Cardio-vasculaire: essentiellement sont les accidents thromboemboliques
 - ❖ Respiratoires:
 - L'encombrement bronchique
 - Les infections respiratoires basses
 - Les accidents liées au déplacement de la sonde de gavage.
 - ❖ Urinaires et digestives:
 - L'incontinence urinaire ou fécale
 - La formation d'un fécalome ou d'un globe vésicale
 - Les infections urinaires
 - L'anorexie
 - ❖ Cutanées: les escarres
 - ❖ Rhumatologiques:
 - Complications ostéo-articulaires
 - A l'extrême on peut observer un syndrome de régression psychomoteur avec des troubles posturaux statiques

- **Q) Les signes annonciateurs d'une crise d'asthme sont**

- la toux,
 - l'essoufflement,
 - les sifflements,
 - l'oppression thoracique
- 
- Les 4 signes majeurs annonciateurs d'une crise d'asthme

- Une difficulté à respirer
- La respiration qui s'accélère
- Une fatigue
- Les yeux qui piquent, qui grattent ou qui coulent
- Le nez qui coule
- La gorge qui gratte, qui pique ou qui fait mal
- Des éternuements
- Un mal à la tête
- Un changement de comportement
- Un changement de couleur de la figure
- Des cercles noirs autour des yeux
- Une chute du Débit Exploratoire de Pointe

- **Q) la nutrition parentérale consiste à:** Alimenter le malade par voie intraveineuse

- **Q) Les conséquences d'une hernie étranglée sont:**
 - Ischémie des viscères étranglés
 - Occlusion intestinale mécanique
 - Hyperthermie liée à l'infection (péritonite)
 - La douleur intense
- **Q) Le vaccin contre la tuberculose se compose de:** Germes vivant atténues
- **Q) les maladies à transport hydrique:**
 - Le choléra
 - La dysenterie
 - La fièvre typhoïde
 - L'hépatite A
 - La poliomyélite
- **régime d'assurance maladie pour les étudiants marocains et étrangers l'enseignement privé et public et de la formation professionnelle/** a été instauré en 2015. Il couvre environ 260 000 bénéficiaires.
- **Les signes cliniques de la typhoïde sont :**
 - a) Fièvre prolongée
 - b) Céphalées/ Vertiges et asthénie
 - c) Ascite

- **Q) les indications de la colostomie définitive:**
 - Cancer du rectum
 - Ablation du sphincter anal
- **Q) les maladies immunisantes:**
 - La coqueluche
 - Les oreillons
 - La scarlatine
 - La rougeole
 - La rubéole
 - La diphtérie
- **Q) Le régime diététique à conseiller à un enfant atteint de syndrome néphrotique :**
 - Régime sans sel plus restriction hydrique
 - apport protéique suffisant pour compenser la protéinurie
 - Régime hypolipidique
 - Régime pauvre en sucre ajouté si ttt par corticoïdes
- **Le pansement gras consiste à :**
 - Faire un pansement avec de la pommade
 - Faire un pansement avec des colloïde

- **Q) La fibroscopie digestive est un examen qui permet de diagnostiquer:**
(Appelée aussi fibroscopie oeso-gastro-duodénale)
 - ❖ **Indications:**
 - saignements digestifs, de douleurs ou de troubles digestifs persistants
 - pour rechercher des lésions inflammatoires (œsophagite, gastrite, etc.)
 - ulcère gastrique ou du duodénum ou de l'œsophage
 - pour dépister des lésions cancéreuses
 - ou encore pour étirer ou élargir une zone rétrécie de l'œsophage (sténose).
 - ❖ **CI:** varices œsophagiennes
- **Q) L'hystérosalpingographie:**
 - ❖ **Indications:**
 - Bilan de stérilité (indication de loin majoritaire) ;
 - Bilan de fausses couches à répétition ;
 - Bilan de fausse couche tardive ou d'un accouchement prématuré ;
 - Bilan de méno-métrorragies (saignement d'origine utérine) ;
 - Exploration complémentaire lors de la découverte d'une image échographique intra-utérine anormale.
 - ❖ **Contre indications:**
 - Grossesse ;
 - Infection génitale évolutive.

- **Les causes des convulsions:**

- Epilepsie
- Tétanos
- Hypocalcémie
- Hypokaliémie
- Hypoglycémie
- Les infections (méningite...)
- Hyperthermie
- AVC
- Traumatisme crânien
- HTA
- Éclampsie
- Tumeur du CNC
- Elévation de l'urée dans le sang
- Trouble hormonal
-

- **Q) l'insertion du DIU:**

- Dans les 5 1ers J du cycle de préférence les derniers jours des règles.
- 6 semaines après un accouchement ou un avortement
- 3 mois ou plus après une césarienne
- Dans le cas d'une femme en aménorrhée l'insertion du DIU est possible après avoir éliminer une grossesse
- Chez la femme qui veut changer la méthode contraceptive, elle peut se faire poser un DIU pendant les prochaines règles.

- **Q) Les buts de la ponction sternale est de faire :**

- Un examen cytologique de la moelle
- Un examen bactériologique de la moelle
- Un examen histologique de la moelle
- Un examen parasitologique de la moelle
- Un examen cytogénétique de la moelle

- **Q) L'urographie intraveineuse permet l'exploration du fonctionnement:**

est un examen radiologique qui permet de visualiser la totalité de l'appareil urinaire (reins, vessie, uretères et urètre), et d'évaluer le fonctionnement des reins, après injection d'un produit opaque aux rayons X qui se concentre dans l'urine.

- **Q) La surveillance d'un patient après une ponction lombaire consiste à :**
 - allonger le patient à plat, sans oreiller
 - prendre les constantes du patient régulièrement toutes les deux premières heures (pouls, tension)
 - le patient reste à plat sans oreiller pendant 4 heures strictes
 - si autorisation peut boire et manger 2 heures après la ponction lombaire
 - surveiller les signes de nausée, céphalée, conscience, signaler tout signe anormal (torpeur, doubleur, trouble respiratoire)
 - Surveiller le point de ponction
- **Q) L'infection nosocomiale:** est une infection clinique et/ou microbiologique contractée dans des établissements de soins par tout patient n'ayant pas cette infection lors de son admission et qui se déclare :
 - Au moins 48 heures après l'hospitalisation , Ce délai est étendu à 30 jours lorsque l'infection a lieu à l'endroit où une opération chirurgicale a été réalisée.
 - Jusqu'à un 1 an pour la pose d'une prothèse .

- **Q) les éléments mentionnés dans la constitution marocaine de 2011 en relation avec le domaine de la santé, tout en précisant l'article de référence :**
- **L'article 31:** stipule que « l'état, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits:
 - aux soins de santé
 - à la couverture médicale
- **L'article 154:** précise que « Les services publics sont organisés sur la base de l'égal accès des citoyennes et citoyens, de la couverture équitable du territoire national et de la continuité des prestations ».
- **article 34** qui stipule que « Les pouvoirs publics élaborent et mettent en œuvre des politiques destinées aux personnes et aux catégories à besoins spécifiques. A cet effet, ils veillent notamment à :
 - Traiter et prévenir la vulnérabilité de certaines catégories de femmes et de mères, des enfants et des personnes âgées,
 - Réhabiliter et intégrer dans la vie sociale et civile les handicapés physiques sensori-moteurs et mentaux et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à tous ».

- **Q) Classement par ordre décroissant des maladies cibles de vaccination selon leur taux d'incidence (enfants de – 5ans en 2013):**

- Tuberculose
- Rougeole
- Coqueluche
- Tétanos
- Diphtérie

- **Q) Les facteurs favorisant l'installation d'une phlébite :**

- Intervention chirurgicale (surtout orthopédique).
- Immobilisation d'un membre inférieur (plâtre, attelle).
- Alitement prolongé.
- Grossesse.
- Longs voyages, notamment en avion.

- **Q) le règlement rendant obligatoire la déclaration des maladies infectieuses au Maroc a été publié en : 1967**

- **Q) Les indicateurs de résultats immédiats portent sur :**

- La notion d'efficacité
- La notion de productivité

- **Les missions du pole des soins infirmiers:** (PSI structuré en 2 ou + bureaux)
 - La coordination et la planification des activités et programmes de soins et services paramédicaux
 - L'évaluation de leur qualité et performance
 - Contribution à la prévention des infections nosocomiales
 - Planification et gestion des ressources destinées au personnel paramédical
 - Contribution à l'élaboration et suivi des programmes d'éducation sanitaire
 - Contribution au développement de la recherche en soins infirmiers
- **Les signes l'acidocétose diabétique**
 - a) Déshydratation
 - b) Dyspnée
 - c) Abaissement du pH sanguin
 - d) Sueurs abondantes
 - e) Augmentation de la pCO₂
- **La prévention de TB se fait par:**
 - la vaccination (BCG)
 - chimioprophylaxie

- **Q) Les signes d'OAP:**

- dyspnée brutale
- Angoisse
- Crachats teintés de sang
- Cyanose
- Transpiration
- Polypnée
- Parfois asphyxie

- **Q) le rôle infirmier durant une séance d'hémodialyse:**

- La préparation du matériels: générateur, montage du CEC, purge, préparation dialysat
- Accueil du patient: prise de poids à l'entrée, installation dans son lit, prise de TA/ Pouls/ T°
- Avant le bronchement, vérifier les différentes paramètres inscrites dans le cahier selon les PM: (dialyseur, médicament...)
- Puis la programmation du générateur: (temps de séance, perte de poids, variation de poids, T° du dialysat)

❖ Bronchement:

- La ponction de l'abord vasculaire
- Effectuer le KT par 2 infirmiers avec une asepsie rigoureuse et selon un protocole de soins établi
- Après le bronchement recontrôler la TA
- Noter sur la feuille de la séance: (l'heure de bronchement, et débranchement, le débit de sang, PV...)
- Après le bronchement le patient prendra une collation ou un reps pendant les 2 1ers H
- Noter toutes les heures la TA/pouls et paramètres de la machine
- Interroger le patient sur son état tout au long de la séance
- Lors de la dernière heure l'infirmier prépare son débranchement

❖ Le débranchement:

- Prélever le bilan sanguin si cela a été prescrit
- Débrancher la malade
- Prendre la TA couchée/debout (hypotension orthostatique)
- Peser le malade à la sortie et noter tous les éléments nécessaires dans le dossier de soins pour le suivi

- **Q) Les symptômes de l'occlusion intestinale:**

- ❖ Une occlusion dans l'intestin grêle

- Des crampes abdominales assez intenses, se produisant à intervalles de 5 à 15 minutes (cycle plus rapide en cas d'obstruction proximale, plus lent en cas d'obstruction distale);
- Des nausées;
- Des vomissements;
- De la diarrhée (initialement, par vidange accélérée de la partie de l'intestin en aval de l'obstruction);
- Des ballonnements;
- Un arrêt total de l'élimination des selles et des gaz;
- De la fièvre.

- ❖ Les symptômes d'une occlusion au côlon sont principalement

- Un abdomen gonflé ;
- Une douleur abdominale, diffuse et modérée ou aiguë et intense, selon la cause de l'obstruction ;
- Un arrêt total de l'élimination des selles et des gaz.

- **Q) les soins infirmiers en cas de fracture de bassin:**
 - Bilan sanguin
 - Surveillance urinaire: hématurie, globe vésical
 - Surveillance hémodynamique: TA, pouls, coloration de la peau
 - Surveillance neurologique: sensibilité, motricité
- **Q) les signes d'une fracture de bassin:**
 - Douleur intense
 - Impotence fonctionnelle
 - Déformation
 - Raccourcissement du membre inférieur
 - Signes de choc
- **Q) les déterminants de la santé font intervenir les éléments suivants:**
 - Infrastructures sanitaires
 - Environnement économique
 - Le mode de vie de l'individu
- **Q)Le PNI:** cible 11 maladies: (la tuberculose, l'hépatite virale type B, la poliomyélite, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche, l'hémophilus influenza type B, les diarrhées à rota virus, les infections à pneumocoque, la rougeole, la rubéole).

- **Q) L'hépatite virale B/**
 - 7ème cause de mortalité dans le monde (2013)
 - Complications graves: cancer
- **Q) l'isolement septique:** est un indiqué dans 3 types de situations:
 - 1) Lorsqu'un patient atteint d'une infection naturellement contagieuse (ex: fièvre typhoïde, varicelle)
 - 2) Lorsqu'un patient est infecté par un agent infectieux spontanément non infectieux mais susceptible de disséminer dans l'environnement et d'être transmis à un autre patient (transmission croisée) via les mains du personnel ou le matériel (ex: infection urinaire à bacille g-sur sonde)
 - 3) Lorsqu'un patient porteur ou excréteur d'un agent infectieux multi-résistant aux ATB.
- **Q) l'isolement protecteur:** est indiqué lorsqu'on veut protéger un patient fragile ou immunodéprimé.
- **Q) pour les bénéficiaires du RAMED:** la contribution concerne seulement la population en situation de vulnérabilité.

- Q) système CV:

- Les veines pulmonaires s'abouchent dans l'oreillette gauche
- Le gros tronc artériel issu du ventricule gauche est l'aorte
- Le septum est la cloison séparant les 2 ventricules
- Les artères coronaires sont des branches de l'aorte, elles assurent la vascularisation du cœur.
- La révolution cardiaque la diastole correspond à la phase de repos
- Les veines pulmonaires sont des vaisseaux afférents (se rattachent) du cœur
- L'artère pulmonaire est un vaisseau efférent (صادر) du cœur
- Les veines caves sont des vaisseaux afférents du cœur

- Q) IC:

- ❖ L'ICG: est due à une anomalie de contraction
 - Son évolution est par poussées
 - Parmi ces symptômes: la dyspnée d'effort
- ❖ L'OAP: correspond à l'inondation des alvéoles par le plasma

❖ L'IVD:

- Le régime SS fait partie du TTT
- La turgescence jugulaire est un élément clinique
- L'asthénie est l'un des symptômes

❖ Le choc cardiogénique:

- L'infarctus du myocarde est l'un des étiologies
- Le malade est agité ou comateux
- Il est dû à une défaillance primitive de la pompe cardiaque

❖ L'artériopathie des MI:

- La gangrène est une des complications
- La PEC au stade IV correspond à l'amputation
- Essentiellement due à l'athérome

❖ Thrombose et embolie pulmonaire:

- Les D-dimères servent pour le diagnostic
- Il s'agit de l'inflammation d'une veine le plus souvent profonde
- Les signes d'appel sont douleur, rougeur, et chaleur

❖ L'embolie pulmonaire:

- Le choc cardiogénique peut être une complication précoce
- Elle est la conséquence de l'oblitération totale ou partielle des artères pulmonaires
- La dyspnée brutale fait partie des signes fonctionnels

❖ Les maladies thromboemboliques:

- Le cancer, l'immobilisation et la chirurgie dans les 3 derniers mois sont des facteurs favorisant acquis.

La prévention:

- La mobilisation active et passive des MI est un moyen de prévention
- Le lever précoce est un moyen de prévention sur PM
- La contention des MI sur PM est un moyen de prévention

Le TTT:

- Le TTT curatif anticoagulant évite l'extension de la phlébite et la récurrence d'embolie pulmonaire
- Le relais anti-vit K est un relais immédiat sauf en cas de cancer évolutif
- Il faut expliquer au patient le rôle de TP et de l'INR
- Bas du formulaire

- **Q) Rhumatismes et dégénérescence des articulations:**

- ❖ La douleur en rhumatologie:

- La douleur inflammatoire est présente au repos. Elle provoque des réveils nocturnes.
- La douleur mécanique est aggravée par l'effort

- ❖ L'arthrose des membres:

- L'arthrose est une usure du cartilage articulaire
- Il y a alternance des périodes douloureuses et non douloureuses
- Dans les arthroses la VS et CRP sont normales
- Il y a un retentissement sur les activités quotidiennes

- ❖ La goutte:

- C'est une maladie articulaire provoquée par l'hyperuricémie
- Le stress est un facteur favorisant
- L'étude du liquide synovial est un élément indispensable au diagnostic
- concernant son régime il faut éviter/ limiter les aliments riches en purine, l'alcool et les fruits de mer; limiter la consommation de tous les types de viandes (120 à 180g)
- bonne hydratation et limiter la consommation des gras saturés, augmenter la consommation de vitamine C

- ❖ Polyarthrite rhumatoïde:

- Elle entraîne une destruction articulaire à long terme
- Elle s'agit d'une maladie auto-immune
- La corticothérapie est l'un des TTT

- **Q) appareil rénal et lithiase urinaire:**

- ❖ **Les lithiases:**

- Une diurèse insuffisance est un facteur favorisant
- L'adénome du prostate est un facteur anatomique favorisant
- Il s'agit d'une cristallisation des sels minéraux

- ❖ **Les reins:**

- Les reins jouent le rôle de station d'épuration
- Ils filtrent le plasma sanguin
- Le débit sanguin rénal correspond à 25% du débit cardiaque

- ❖ **La colique néphrétique:**

- La fièvre est un signe de colique néphrétique compliqué
- Les patients sont souvent très agités
- La douleur évolue par crise
- L'hématurie fait partie des signes cliniques

- **Les examens complémentaires de la colique néphrétique:**

- la créatinémie, l'échographie, et en fait une bandelette urinaire à la recherche d'une hématurie et/ou des nitrites

Le TTT de la colique néphrétique:

- Une sonde urétérale ou sonde JJ peut être posée
- La surveillance de la douleur et de la T° est primordiale
- Une perfusion VC des AINS et spasfon est souvent posée

- **Les formes galéniques:**

- ❖ L'absorption d'un médicament par voie orale:

- Elle est synonyme de résorption
- Elle nécessite le franchissement de 2 barrières: intestinales et capillaires
- Elle est modifiée par l'alimentation

- ❖ La libération prolongée d'un médicament: permet de diminuer le nombre de prises par jour

- ❖ La voie orale: ne permet pas d'échapper à l'effet de 1^{ER} passage hépatique

- ❖ Le comprimé effervescent: est une forme orale à libération prolongée

- ❖ La forme orale à libération accélérée: permet une meilleure tolérance gastrique

- ❖ Le comprimé à matrice: est une forme orale à libération prolongée

❖ La forme galénique:

- elle peut être une solution, suspension ou une émulsion
- Elle doit être stérile

❖ Les formes galéniques destinées aux voies aériennes supérieures:

- L'aérosol
- La solution pour nébulisation

❖ Le comprimé dispersible: forme galénique ne fait pas partie des formes transmuqueuse

❖ La voie IM: est la VA sans effraction

❖ Le comprimé gastro-résistant: libère le principe actif dans l'intestin

❖ Les capsules et les gélules: ont une action rapide

❖ Les gélules: peuvent contenir des micro granules

❖ Dans la voie sublinguale: il y a résorption par voie transmuqueuse

❖ Les comprimés enrobés:

- Sont des comprimés à libération immédiates
- Quand l'enrobage est fin, on parle des comprimés pelliculés
- L'enrobage peut permettre de masquer une saveur désagréable

- **Q) système digestif:**
 - ❖ le pancréas: est une glandes annexes du tube digestif
 - ❖ la digestion: permet d'obtenir des éléments simples
 - ❖ La bouche: fait partie du tube digestif
 - ❖ L'estomac: est une poche dilatée
 - ❖ Le pharynx: est la carrefour aéro-digestif
 - ❖ L'œsophage: traverse le diaphragme
 - ❖ La physiologie de la digestion:
 - la digestion possède une fonction sécrétoire
 - Elle transforme en nutriments les éléments assimilables
 - La digestion est composée de 4 fonctions différentes (1) mastication, 2) déglutition, 3) transformation des aliments en nutriments, 4) absorption)
 - ❖ la physiologie du tube digestif:
 - Le péristaltisme: est le passage des aliments dans l'œsophage
 - La déglutition est composée de 4 étapes (1) la phase préparatoire à la déglutition, 2) la phase orale ou buccale, 3) la phase pharyngée, 4) la phase œsophagienne)
 - Les aliments sont brassés puis évacués vers le duodénum.

❖ L'absorption intestinal:

- Le tube digestif transport une quantité totale de 9l liquide
- L'organisation anatomique de la muqueuse intestinale est représentative de ça fonction, cela correspond au passage des nutriments à travers l'intestin grêle.
- **Q) les effets secondaires des corticoïdes:** (les corticoïdes agissent comme la cortisone qui est une hormone) ses ES sont:
 - Une diminution de la réponse immunitaire
 - Des désordres hydro-électrolytiques: la rétention hydro-sodée se manifeste par des œdèmes des MI et de l'hypertension, le régime hypo-sodé se révèle indispensable, il peut y avoir une hypokaliémie
 - Des troubles cutanées: (amincissement cutané, et un érythème des pommettes; le teint est gris
 - Des troubles endocriniennes et métaboliques: (l'effet hyperglycémiant nécessite le contrôle de la glycémie)
 - Des troubles musculo-squelettiques: (ostéoporose à long terme)
 - Des troubles digestives avec risque d'ulcère gastroduodénal ou de réveil d'un ulcère préexistant
 - Des troubles neuropsychiques

- **Q) La classification des diurétiques:** On distingue trois catégories principales de diurétiques en fonction des sites d'action au niveau du tubule rénal:
 - **Les diurétiques de l'anse:** furosémide (Lasilix®), bumétanide (Burinex®), pirétanide (Eurelix®) ; ils inhibent la réabsorption de sodium dans la branche ascendante de l'anse de Henle.
 - **Les diurétiques thiazidiques:** ce sont des dérivés du benzothiazide, et sont donc des sulfamidés : hydrochlorothiazide (Esidrex®), chlortalidone (Hygroton®), indapamide (Fludex®). Ils inhibent la réabsorption de sodium sur la partie proximale du tube distal, au niveau du segment de dilution.
 - **Les diurétiques du tube collecteur cortical (les diurétiques distaux):** ils regroupent l'amiloride (Modamide®) et les antialdostérones, spironolactone (Aldactone®), éplérénone (Inspra®) ; ils ont en commun la capacité de s'opposer à l'échange Na/K.
- **Q) la surveillance à mettre en place devant les ES de la morphine:**
 - ❖ **La constipation:**
 - Surveillance alimentaire: augmenter l'apport des fibres dans l'alimentation
 - Prévention systématique par les laxatifs

❖ Les nausées et vomissements:

- Surveillance de l'état générale du patient
- Administration des antiémétiques
- Si apparaissent en cours de traitement, éliminer une cause métabolique, organique ou psychogène

❖ La rétention urinaire:

- Toute agitation chez un patient sous morphine est suspecte d'être liée à un globe vésical.
- Surveillance systématique des mictions et de la diurèse chez tous les patients sous morphine.
- Diminution de la morphine si le contrôle de la douleur le permet

❖ SEDATION OU SOMNOLENCE:

- Diminution de la posologie de morphine.
- Réévaluer les médications associées qui peuvent majorer la sédation. Envisager de changer de morphinique.
- Attention à la survenue concomitante de myosis, signe d'imprégnation morphinique.

❖ DEPENDANCE PHYSIQUE: arrêter progressivement le TTT morphinique

- **Q) la PEC d'une personne victime d'un arrêt cardiovasculaire en dehors du milieu hospitalier:**

- Appeler immédiatement les secours les plus proches
- Donner une alerte précise avec une localisation détaillée en précisant que la victime est en arrêt circulatoire
- Commencer immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire en commençant par la libération des VA qui est réalisée par la sub-luxation du maxillaire ou la traction du menton vers la haut
- Puis commencer la ventilation de secours par le bouche à bouche, si l'insufflation est un impossible, et associer un massage cardiaque externe si absence de pouls en effectuant un alternance de 15 compressions pour 2 insufflations: en réalisant 4 cycle de cet alternance de 15 MCE pour 2 insufflations par minute

- **Q) Les signes d'asthme aigu grave :**

- une grande difficulté à respirer (respiration rapide et courte, espace entre les côtes et au-dessus des clavicules se creuse) ;
- les lèvres et les ongles bleuissent ;
- des difficultés à parler ou à marcher ;
- une confusion ou une perte de connaissance.

- Q) l'hypothermie:

- ❖ Grandes lignes de TTT:

- Le réchauffement lent: (1°C/h); (externe couverture chauffante) ; (interne perfusion réchauffée, lavage gastrique chaud, dialyse péritonéale à 37°C-40°C)
- L'oxygénation
- Le remplissage vasculaire sous contrôle hémodynamique (sonde de Swant-Gantz)
- Les drogues cardio-vasculaires
- Les apports énergétiques (glucose à 10%)

- ❖ Complications à redouter lors d'une hypothermie grave:

- Collapsus par hypo-volémie due à la vasodilatation du réchauffement
- Fibrillation ventriculaire
- Pneumopathie
- Hémorragie digestive par ulcère de stress
- IRA
- Pancréatite hémorragique

- **Q) indications des corticoides:**

- Insuffisance surrénalienne
- RAA
- Asthme
- Leucémie

- **Q) Les 6 fonctions des ESSP:**

- Fonction de soins
- Fonction de santé publique
- Fonction d'organisation et de gestion
- Fonction de formation et d'encadrement
- Fonction de communication et de liaison
- Fonction de développement communautaire et de collaboration intersectorielle

- **Q) les outils utilisés pour prioriser les problèmes de santé:**

- Technique de groupe nominale
- Grille de priorisation des problèmes
- La méthode de QQOQCP

- **Q) la planification exige des habiletés:**

- Techniques
- Politiques
- De négociation
- De communication

- **Q) les missions des ISPITS:**

- La formation de base
- La formation continue
- La recherche scientifique et technologique
- L'organisation des services et des soins infirmiers
- Le développement de la profession infirmière et des techniques de santé
- Le renouvellement des pratiques et techniques de santé
- La réalisation des expertises liées aux domaines des professions infirmières et des techniques de santé

- **Q) Parmi les approches en santé publique:**

- L'approche pluridisciplinaire
- L'approche multisectorielle
- L'approche verticale par problèmes de santé
- l'approche horizontale par méthode de service
- La participation communautaire

www.ispits.net

} A. Santé publique

- **Q) les outils de la santé publique:**

- Epidémiologie: études, enquêtes épidémiologies,
- Économie: outils d'évaluation économique
- Démographie: pyramide des âges, indicateurs démographiques
- Gestion: planification, évaluation, GRH
- Sciences humaines: sociologie
- Formation: méthode pédagogiques

- **Q) les indications de l'UIV:**

- Coliques néphrotiques fréquentes
- Infections à répétition
- Sans dans les urines

- **Q) le nombre des membres de la commission nationale de l'offre de soins:** 26
- **Q) les concepts fondamentaux de l'économie:**
 - La rareté des ressources
 - Le choix, la décision
 - Le cout d'opportunité
 - L'efficience économique
- **Q) les acquis non contestés dans le secteur de la santé:**
 - Maitrise de l'accroissement démographique
 - Gain important en espérance de vie
 - Accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile
- **Q) les principales contraintes du développement du système de santé:**
 - Difficultés d'accès aux soins
 - Importances des paiements directs des ménages
 - Pénurie aigue en ressources humaines de santé

- **Q) Les objectifs du développement du secteur de la santé:**
 - décliner les dispositions de la nouvelle constitution
 - Mettre en œuvre le programme du gouvernement
 - Consolider les acquis en matière de programmes sanitaires
 - Répondre aux attentes essentielles de la population et aux nouveaux défis liés à la santé (nouvelles priorités)
 - Restaurer un climat de confiance entre les parties prenantes du secteur
- **Q) la formulation stratégique du plan sectoriel 2012/2016 est basée sur les approches suivantes (élaboration de santé):**
 - Une approche fondée sur les droits
 - Une approche de démocratie sanitaire
 - Une approche de renforcement du système de santé
- **Q) les caractéristiques de la transition dans le domaine de la santé:**
 - La croissance démographique
 - L'augmentation de l'espérance de vie
 - La diminution du taux de fécondité

- **Q) l'information des patients:**

- par définition l'information doit être claire loyale et appropriée
- Le droit à l'information connaît des exceptions
- Le droit à l'information est exclu par principe pour le mineur ou le majeur sous tutelle
- Elle a pour objectif d'éclairer le consentement

- **Q) la surveillance épidémiologique:** est un processus composé de 4 activités principales:

1. La collecte de données pertinentes sur une population et une région spécifique
2. Regroupement et tabulation de ces données sous une forme significative et exploitable
3. Analyse et interprétation des données
4. Diffusion des données et résultats aux personnes et services intéressés

- **Q) la TA correspond:**

- À la contraction (systole) et au relâchement (diastole) du cœur
- À la pression du sang dans les artères

- **Q) pour parler de constipation 3 éléments doivent être retrouvés:**

1. Moins de 3 selles par semaine
2. Evacuation difficile
3. Selles sèches (déshydratées)

- **Q)les indicateurs de santé:**

- ❖ Objectifs:

- Décrire
- Évaluer
- Comparer
- Surveiller

- ❖ Mesures: (toute mesure à un numérateur et un dénominateur)

- Proportion (dénominateur inclut le numérateur)
- Indice (rapport des effectifs de 2 variables)
- Taux (notion de risque et notion de temps)
- Ratio (variable à 2 modalités)

- **Q) la charge des maladies non transmissibles:** représente 75% de tous les décès

- **Q) les caractéristiques de la santé communautaire:**

- L'implication de la population
- Le repérage collectif des problèmes, des besoins et des ressources
- La participation et ouverture à toutes les acteurs
- Le décroisement professionnel

- **Q) les missions des systèmes de soins:**

- Identification des besoins
- Choisir les priorités et l'action
- Mettre en œuvre une politique de santé adapté aux besoins

- **Q) dans le cadre du SS 2107/2021:** le MS vise:

- Le renforcement du programme nationale des maladies non transmissibles (cancer, diabète, cardiopathies, IR terminale), et le PLAT.
- La PEC de la santé mentale
- Le lancement de nouveaux programmes:
 - Programme de lutte contre la surdité
 - Programme de PEC de l'hépatite virale

- **Q) la dentition définitive:** double vers l'âge de 6 ans
- **Q) le financement des hôpitaux publics:** 77% (l'état) 23% (recettes propres)
- **Q) le secteur de la santé:** se trouve interpellé de façon directe à travers l'axe réservé à la garantie de l'accès aux soins
- **Q les nouveaux programmes lancés par le MS dans pour atteindre les ODD vers 2030:**
 - Programme de lutte contre la surdité
 - Programme de lutte contre l'hépatite virale
- **Au Maroc la prévention de l'hépatite B est basée sur :**
 - a. Le dépistage prénatal
 - b. c. Le dépistage en transfusion sanguine
 - d. Le dépistage prénuptial
 - e. La vaccination dans le cadre du Programme National d'Immunisation

- **Q) la sonde gastrique:**

- ❖ Indications:

- Hémorragie digestive
- Lavage gastrique
- Évacuation du contenu gastrique chez un malade inconscient
- Chirurgie viscérale (tube digestive)

- ❖ CI:

- Traumatisme crânio-faciale: risque de passage au travers la base du crâne

- **Q) Soins post-opératoires de l'UGD:**

- L'aspiration gastrique
- ATB à large spectre
- ATS

- **Q) le développement de la santé en milieu rural:**

- Renforcement de la stratégie de couverture sanitaire fixe
- Renforcement de la couverture sanitaire mobile
- Développement de la participation communautaire

- **Q) renforcement de la stratégie de couverture sanitaire fixe:**

- Opérationnalisation des structures fermées pertinentes
- Construction des logements de fonctionnement
- Renforcement du plateau technique des CSCA
- Renforcement de la disponibilité du médicament
- Amélioration du transfert à partir des unités UMP

- **Q) renforcement de la couverture sanitaire mobile:**

- Mise en œuvre du plan national des compagnes médicales spécialisés et mobilisation des ressources nécessaires
- Renforcement des moyens de mobilité pour la couverture médicale mobile
- Renforcement du plateau technique des unités mobiles
- Mobilisation des ressources nécessaires pour la couverture sanitaire mobile
- Renforcement des compétences des prestataires de soins en gestion des unités médicales mobiles

- **Q) la tuberculose:**

- Environ 28.000 nouveaux cas de tuberculose ont été dépistés au Maroc en 2013
- Incidence de 82 nouveaux cas pour 100.000 habitants.
- **70%** des cas dépistés sont concentrés dans les zones les plus urbanisées, particulièrement autour des grandes villes
- les hommes (**58 %** des cas) plus que les femmes (42%)
- **70%** des cas, la tuberculose touchait une population jeune et active d'âge compris entre 15 et 45 ans
- la résistance primaire: chez les jamais traités par des médicaments tuberculeux et qui ont été contaminés par des bacilles résistants émis par des malades déjà traités.
- la résistance secondaire ou acquise; (chimiothérapie inadéquate)

- **les signes du choc hémorragique:**

- hypotension
- tachycardie et polypnie
- confusion modérée ou agitation avec son somnolence, obnubilation, coma
- marbrures, peau froide, cyanose et sueurs
- oligurie et soif

- **INSUFFISANCE CARDIAQUE DROITE**

A°étiologie:

- lésion de l'artère pulmonaire
- scléroses des poumons
- lésions mitrales

créent un obstacle ;et exigent un travail accru du VD

- lésions myocardiques: dues à la sclérose;RAA; infection
- dans ce cas le myocarde se contracte mal

B°symptômes:

- Dyspnée: d'effort puis de repos
- OMI:peu marqués au début, plus prononcés à un stade

Plus avancé

- ascite
- hépatomégalie
- autres signes: cyanose,,,

- **Parmi les soins nécessaires en cas de syndrome néphrotique:**

- Mise en oeuvre d'une thromboprophylaxie rigoureuse
- Préparer le malade pour les examens : ECG, radio du thorax, Echographie rénale ; ponction biopsie rénale
- Faire les examens biologiques : dosage sanguin et urinaire l'amylasémie et amylasurie
- Surveiller l'apparition des signes d'infection

le syndrome de wolkman: est causée par une compression de la circulation (lésion artérielle et veineuse)

- **Q) les 3 axes de la nouvelle stratégie 2017/2021:**

- ❖ **Axe1:** L'achèvement des chantiers de réforme et des programmes lancés dans le cadre du gouvernement précédent (stratégie 2012/2016).
- ❖ **Axe2:** Le renforcement de « l'approche service » du secteur de la santé.
- ❖ **Axe3:** Le dépassement la conjoncture essentiellement la pénurie sur le plan quantitatif et qualitatif des ressources humaines de santé.
- ❖ **Axe1:**

1.1. L'extension de la couverture médicale : (les indépendants et leurs ayants droits qui représentent le 1/3 de la population Marocaine).

1.2. Le renforcement de l' accès aux services de santé dans les hôpitaux publics et les ESSP:

- **Renforcer le financement et la gouvernance** du RAMED
- Mettre en œuvre la politique pharmaceutique nationale
- **Encourager la production** nationale des médicaments coûteux
- **Opérationnaliser les dispositions** de la carte sanitaire
- **Mettre à niveau les structures hospitalières publiques** (équipement de chaque CHP d'une TDM et chaque CHR d'une IRM + leur maintenance)

- 1.3. Le renforcement des dispositifs de la Sécurité et de la veille Sanitaire contre les risques et urgences menaçant la Santé de la communauté:
 - **Renforcer** les services de contrôle aux frontières
 - **Appuyer** les laboratoires de référence en santé publiques (dans le moyen terme, l'adoption de la 1ere loi sur la santé publique au Maroc et la création d'une agence nationale de santé publique)
 - **Maintenir et Encourager** les moyens de prévention par l'action sur le changement du comportement et l'adoption des modes de vie sains

❖ **Axe 2:**

- 2.1. Se concentrer sur le renforcement de l'approche service du secteur de la santé entamée dans la stratégie 2012-2016 et son extension à tous les niveaux:
 - **Améliorer les condition** et la qualité de l' accueil dans les établissements de santé essentiellement dans les hôpitaux publics; et l'augmentation du taux de fréquentation de plus de 40% de la pop.
 - **Améliorer la qualité** des services offerts,
 - **Développer le système** de gestion des RV
 - **Régionaliser les procédures** de traitement des plaintes et réclamations des usagers;

- 2.2. Prioriser et Valoriser les actions de proximité comme réforme centrales de soins de Santé primaires. se qui va permettre de réduire les disparités d'accès aux soins de santé de base et l'augmentation de son taux de couverture pour le secteur public de 60% à 100%.
 - **Elaborer les filières** et la hiérarchie des soins pour permettre aux CHU et CHR de se concentrer sur leur missions de soins de 3^{em} niveau
 - **Améliorer la santé** mobile dans le monde rural (mise à disposition de chaque circonscription d'une unité mobile et d'une ambulance/partenariat avec les collectivités territoriales)
- 2.3. l'amélioration de la Santé des populations vulnérables et des personnes à besoins Spécifiques (mise en œuvre de la stratégie nationale de la Santé et l'handicap):
 - **Améliorer de la prise en charge** sanitaires des population des établissement carcérales,
 - **Créer un programme** nationale de gériatrie
 - **Améliorer les condition** de prise en charge de la santé des femmes et enfants victimes de violence et des séropositifs au VIH
 - **Améliorer les services** de santé offerts aux émigrés

Dans le cadre des engagements internationaux du pays pour atteindre les ODD vers 2030 le ministère s'engage à:

- **Renforcer** le programme national des urgences
- **Renforcer** le programme national de la santé de la mère et de l'enfant
- **Renforcer** le programme national des maladies non transmissibles (cancer, diabète, cardiopathies, Insuffisance rénale Terminale)
- **Prendre en charge** de la santé mentale et psychique
- **Renforcer** le programme de la LAT
- **Lancer** de nouveaux programmes :
 - Programme de lutte contre la surdité
 - Programme de Prise en charge de l'hépatite virale

❖ **Axe 3:**

- **3.1. Reprendre le dialogue** sociale et la concertation avec les partenaires sociaux
- **3.2. Développer les postes budgétaires** réservés au secteur de la Santé
- **3.3. instaurer les mesures incitatives** pour la contractualisation avec les médecins du secteur privé pour faire face à la pénurie des RH dans les hôpitaux publics et ESSP
- **3.4. Renforcer les compétences** des professionnels de la santé et des administrateurs

3.5. Travailler pour assurer les bonnes conditions pour la création d'une «fonction publique de santé » pour trouver des solutions efficaces aux problèmes du personnel de santé

3.6. Consolider l'approche participative dans le cadre de la bonne gouvernance des secteurs publics

3.7. Créer les institutions prévues dans la loi cadre 34-09 (conseil consultatif de santé)

3.8. Renforcer l'autonomie financière et administrative des établissements hospitaliers pour la mise en œuvre de la régionalisation avancée

• Les quatre axes stratégiques retenus pour la coopération entre le Maroc et l'OMS 2017/2021/

- ❖ Axe1: Renforcer l'accès équitable des populations à des services de qualité, à un coût abordable, en vue de tendre vers la couverture sanitaire universelle ;
- ❖ Axe2: Contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable, notamment la réduction des inégalités en santé et de la charge de morbidité et de mortalité;
- ❖ Axe3: Renforcer les fonctions essentielles de santé publique et la sécurité sanitaire ;
- ❖ Axe3: Accompagner la dynamique de la régionalisation avancée et renforcer la gouvernance du secteur de la santé.

•Q) les activité de gestion de soins:

- Organisation de soin
- Information et coordination
- Supervision de soins
- Planification de soins
- Qualité de soins

•Q) les missions de l'unité de soins:

- Mission de soins
- Mission de développement professionnel
- Mission de santé publique
- Mission économique et managerielle

• Les complications des angines à répétition mal traitées sont :

- a) Le rhumatisme articulaire aiguë
- b) La glomérulonéphrite aiguë
- c) Les complications cardiaques

- La prophylaxie désigne l'ensemble des moyens visant à lutter contre l'apparition, la propagation et/ou l'aggravation d'une ou plusieurs maladies

les omplications de la pneumonie: (virale: surinfection bactérienne etbactérienne: pleurisie voir abcès du poumon) ces pneumonies compliqués provoquent une importante DR, dans certains cas (pneumoxoques) peut déclancher un choc septoque.

- **Q) les causes de dyspnée:**

- ❖ Cause pulmonaires:

- L'inflammation des bronches
- La contraction des muscles entourant les bronches (crises d'asthme)
- L'augmentation anormale de la taille du poumon (emphysème pulmonaire)
- Modification du tissu pulmonaire causée par une fibrose
- Allergie/ corps étranger
- Obésité
- Faiblesse musculaire (myopathie)
- L'ablation d'un poumon
- Certaines maladies (pneumonie, embolie pulmonaire, laryngite, traumatisme thoracique)

- ❖ Causes cardiaques:

- IC
- Anomalies des valves
- Infarctus du myocarde
- péricardite

- **Q) les types de dyspnée:**

- Expiratoire: (asthme)
- Inspiratoire: (corps étranger, œdème de Quincke)
- D. Cheyne-stokes: respiration cyclique avec augmentation progressive de la fréquence et de l'amplitude des mouvements respiratoires, puis une baisse jusqu'à la pause de la respiration (comas neurologiques, l'acidose urémique)
- D. de kussmaul: gêne respiratoire se traduit en 4 temps: inspiration-pause-expiration-pause (l'acidose métabolique diabétique)

- **Q) le financement du PEH:**

- La Contractualisation: Instrument réglementaire pour la mise en œuvre du PEH et son financement (Budget-programme)
- Le Partenariat: avec les Collectivités locales, les ONG, les donateurs...pour le financement de certaines actions du PEH

- **Q) les types de dépistage:**

- ❖ D. sélectif: sélectif passif dans le formations sanitaires et sélectif actif dans les circuits de surveillance
- ❖ D. de masse: au cours d'un enquête au tours d'un cas ou une intervention de chimiothérapie
- ❖ D. intensif: au niveau des foyers importants de la transmission

- **Q) le bon trajet qu'emprunte l'oxygène dans les voies respiratoires lors de l'inspiration:** Les fosses nasales, le pharynx (carrefour aéro-digestif), le larynx, la trachée, les bronches.
- **Q) Les facteurs influençant l'utilisation des services de santé;**
 - Accessibilité géographique
 - Accessibilité financière
 - Accessibilité psychologique et culturelle
 - Accessibilité institutionnelle
- **Q) le régime hyposodé est:**
 - ❖ indiqué en cas de:
 - Etat œdémateux d'origine cardiaque ou hépatique.
 - Hypertension artérielle.
 - Corticothérapie.
 - ❖ Contre indiqué en cas de:
 - Insuffisance surrénalienne.
 - Traitement par lithium.
 - grossesse

- **Q) les outils pour analyser un problème de santé:**
 - Organigramme
 - Diagramme de cause-effet (D'ishikawa)
 - Instrument pour la collecte des données
- **Q) les déterminants de l'utilisation des services de santé:**
 - Dimensions liées à la structure et à l'organisation de service
 - Dimensions liées au professionnel de santé
 - Dimensions liées à la population
- **Q) Le Brainstorming :** est une technique qui à pour but de produire un maximum d'idée pour comprendre où résoudre un problème
- **Q) Les principes de la gestion de la qualité sont:**
 1. le leadership
 2. Orientation vers le client
 3. Le travail en équipe
 4. L'utilisation des données
 5. Analyse des systèmes et des processus
- **Q) La formulation du PEH repose sur 2 logique:**
 - Logique professionnelle
 - Logique de projet

- **Q) diagramme de cause à effet ou d'ishikawa se compose de:**

1. Matière
2. Milieu
3. Méthodes
4. Main d'œuvre
5. Moyens (matériel)

- **Q)L'amyloïdose, parfois appelée amylose:** désigne un groupe de pathologies rares caractérisées par la présence de fragments de protéines dans les tissus. Ces dépôts insolubles peuvent se fixer sur différents organes tels que le cerveau, le cœur, les reins, les yeux ou le foie.

- **Q) Les instances de concertation en matière de santé (pour améliorer la gouvernance du SNS):**

1. Un conseil national consultatif de la santé.
2. Un comité national d'éthique.
3. Une commission nationale consultative de coordination entre le secteur public et le secteur privé.
4. Une commission nationale et des commissions régionales de l'offre de soins.
5. Un comité national de veille et de sécurité sanitaires.
6. Un comité national d'évaluation et d'accréditation.

- **Q) les objectifs d'un SNS: (OMS; 2007):**

- Amélioration de la santé (niveau et équité) www.ispits.net
- Protection contre les risques financiers et sociaux
- Amélioration de l'efficience
- Identifier et répondre besoins de la population (rôle de l'épidémiologie)
- Déduire les priorités
- Mettre en place les actions nécessaires

- **Q) La réforme du système de santé marocain repose sur:**

- ❖ 4 choix stratégiques:

- La régionalisation
- L'approche du système de santé intégré
- La réforme du financement: avec ces 2 mécanismes AMO et RAMED
- La réforme hospitalière: qui vise la préparation des hôpitaux à la transition à l'autonomie et à la mise en place de l'assurance maladie

- ❖ Leviers d'action: représentent les actions motrices de la réforme de santé

- L'institution d'équipes régionales de planification
- Le développement d'un système d'information informatisé
- La promotion de l'assurance qualité
- L'introduction des nouveaux mécanismes de régulation (CS, SROS, PEH, contractualisation

- **Q) Modèle de Système de santé au Maroc (loi 34, 09):**
 - Pyramidal
 - Intégré
 - Hiérarchisé
 - Fondé sur les SSP
- **Q) Les critères pour la réalisation d'un prélèvement de sang sur lame dans le cadre du dépistage du paludisme seront fonction de la zone concernée**
 - ❖ Critères en zone urbaine :
 - fièvre + signes très évocateurs du paludisme (anémie, céphalées, nausées et vomissements...);
 - notion de séjour dans une zone endémique à l'intérieur ou à l'extérieur du pays (Afrique du Sahara, Amérique Centrale et du Sud, Asie).
 - ❖ Critères en zone impaludée :
 - fièvre (maître symptôme)
 - antécédents fébriles.
 - ❖ critères en zone indemne de paludisme:
 - fièvre inexpliquée
 - indication épidémiologiques particulières, transfusion sanguine
 - séjour dans une zone endémique à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.

- **Q) La circonscription sanitaire: assure les prestations relatives:**

- La prévention
- La promotion de la santé et des modes de vie sains
- l'accouchement
- Les UMP
- Médecine générale

- **Q) CMB:**

- ❖ AMO: Couvre 13,1M 40% en 2013 (10,7M 34% en 2010 et 7,6M 25%)
- ❖ RAMED: couvre 9,7M en 2016 (8,5M 28% en 2010)

- **les instances de gouvernance du RAMED:**

- ANAM: «gestion financière » et cartes RAMED
- MI: pilotage du processus d'éligibilité
- MS: filière de soins et processus de PEC

Parmi les facteurs favorisant les mycoses :

- Les corticoïdes
- Le diabète
- Le milieu buccal acide
- Les antibiotiques

- **La taille de l'enfant double:** 3 ans (4 ans plus sur)

- **Indications du lavage gastrique:**
 - Intoxication alimentaire ou médicamenteuse. Le lavage doit être fait avant 6h avec possibilité de le faire après 6h si les médicaments font un retard au niveau de l'estomac.
 - Avant anesthésie générale en urgence.
 - Sténose du pylore : lavage + évacuation gastrique.
- **indications du tubage gastrique:**
 - ❖ **But diagnostique:** Aspiration gastrique; Recherche du B.K; Lavage d'estomac
 - ❖ **But évocateur:** Ulcère gastrique; Lavage gastrique : intoxication
 - ❖ **Préparation opératoire**
 - ❖ **But thérapeutique:** Réhydratation ; Administ
- dicamenteuse
- ❖ **But alimentaire:** gavage
- **CI du tubage gastrique:**
 - Varices œsophagiennes
 - Tumeur ou obstacle de l'œsophage
 - Sténose du cardia
 - Ulcère gastrique récent
 - Traumatisme crânien (fracture du maxillaire inférieur)
 - Agitation du patient

- **Afin de collaborer dans le diagnostic de la maladie de cushing, l'infirmier doit :**

- a. Surveiller l'état du malade et noter l'apparition des modifications morphologiques, cutanées et psychiques.
- b. Faires les explorations hormonales (cortisolémie de 8heure, de 16heure, de 18heure, cortisol libre urinaire dans les urines de 24heurs sous avis médicale
- c. Faire les examens biologiques prescrits par le médecin : NFS, ionogramme sanguin (kaliémie, calcémie, cholestérol)
- d. Préparer le malade pour les explorations dynamiques (test de freinage à la dexaméthasone (DXM) et le test à la métopirone)

- **devant le diabète insipide l'infirmier doit surveiller:**

- la présence des symptomes d'un ralentissement physique et psychique
- la polyurie, la soif, la polydipsie, la T°, l'agitation et l'angoisse liée à la dyshératation

- **en cas de crise de thyreotoxique(complication d`hyperthyroidie) l'infirmier doit :**

- ✓ Administrer les anti-thyroidiens de synthese,iodeforte dose ou lithium,Beta Bloquant,corticoides IV , conformement a la Prescription medicale (PM) .
- ✓ hospitaliser immediatment le patient en soins intensifs et preparer le Materiel de reanimation .
- ✓ calmer le malade a l`ide de diazepame , conformement a la P.M

- **un porteur de germe**

A. est une personne qui va assurer la diffusion de l'agent pathogène dans la collectivité

B. peut être un porteur sain

C. peut être un porteur chronique

D. peut être un incubant précoce

- **la prévention antipaludienne chez les voyageurs internationaux:**

- dépend de la zone de séjour

- dépend des conditions de séjour

- basée sur la chimioprophylaxie

- basée sur la prophylaxie des piqûres d'anophèles

- **La surveillance dans le TTT par les AIS:**

- ❖ Examens: poids; PA, recherche des foyers infectieux; ECG; IDR; Rx pulmonaire; ostéodensitométrie

- ❖ Biologie: hémogramme; ionogramme sanguin; glycémie A; uroculture; bilan lipidique; examen parasitologique des selles (si notion de région tropicale)

la ponction biopsie rénale

❖ 1/ Indications

- Insuffisance rénale aiguë ou chronique
- Hématurie
- Protéinurie
- Syndrome néphrotique
- Maladies systémiques avec atteinte rénale
- Contrôle du greffon

❖ 2/ Contre-indications

- Coagulation (trouble de la)
- HTA sévère, non contrôlée
- Atrophie rénale
- Malformation rénale et hydronéphrose
- Ectopie rénale (position anormale du rein)
- Anévrisme (micro)
- Unique rein
- Rénale insuffisance chronique avancée avec reins de petites tailles
- Ectasie des voies urinaires (dilatation)
- Infection urinaire non traitée
- Néoplasie rénale

- **Cât immédiat devant un accident transfusionnel:**

- arreter immédiatement la transfusion
- appeler le medecin
- garder la vv avec une perfusion de soluté de NaCl 0,9%
- contrôler régulièrement les signes vitaux si frissons réchauffer le patient
- prélever les tubes pour effectuer le bilan prévu par le protocole défini dans l'établissement par une autre vv que celle utilisée pour la transfusion, les mettre avec l'unité de sang et la carte du test pré-transfusionnel, renvoyer le tout au CRTS pour analyse
- prévenir le correspondant d'hémovigilance
- surveiller continuellement le patient (faciès, signes vitaux, FR)

- **Role infirmier devant OAP:**

- installer le patient à son lit en position 1/2 assise le rassurer, le brancher avec O2; le mettre sous scope + ECG et surveillance des constantes (pouls; fr; TA; diurèse; faciès), faire les bilans et administrer le ttt selon PM
- mettre un haricot pour les expectorations pour savoir leur quantité, couleur, aspect
- lutter contre l'hypoxie: maintenir une saturation > à 95% jusqu'à amélioration de l'état pulmonaire
- limiter le travail cardiaque: repot strict au lit mais il prévenir le risque des escars et dépister les troubles cardiaques

les SSP selon la déclaration d'ALMA ATA 1978: sont définis comme étant des soins de santé essentiels, fondés sur des interventions scientifiquement éprouvées ET devaient être rendus universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles à un coût que la communauté et le pays puissent assumer. Les ssp devaient comprendre huit éléments :

- 1) une éducation concernant les problèmes de santé;
- 2) une nutrition adéquate;
- 3) des soins de santé maternelle et infantile;
- 4) des mesures d'assainissement de base;
- 5) un approvisionnement suffisant en eau salubre;
- 6) la vaccination contre les grandes maladies infectieuses,
- 7) la prévention et le contrôle des endémies locales;
- 8) le traitement des maladies et blessures courantes et la fourniture de médicaments essentiels.

www.ispits.net

les phases d'évolution d'une maladie transmissible:

- ❖ la période d'incubation: l'intervalle qui sépare le 1er jour de pénétration du germe et le jour où apparaît le 1er signe clinique
- ❖ l'invasion: début des manifestations cliniques
- ❖ période d'état: stabilisation relative des symptômes. cette période correspond à une sorte de déséquilibre entre l'agression et la défense de l'organisme, sa durée varie selon l'efficacité de la réaction et du ttt
- ❖ période de convalescence:

- **les signes du marasme:**

- insuffisance énergétique globale et fonte des masses musculaires et graisseuses et déficit pondéral majeur
- peut s'installer dès le 1er mois de la vie
- saillie des côtes et des os des membres
- visage maigre, ridé, yeux enfoncés dans les orbites (aspect de petit vieux)
- ni œdème ni éruption ni troubles de la pigmentation
- pas de lésion cutanée
- appétit conservé: enfant affamé avec diarrhée de la faim: petites selles liquides vertes
- comportement: enfant fatigué mais s'intéresse à ce qui passe autour de lui

- **les signes de kwashiorkor:**

- carence en protéines
- fréquent dans les mois qui suivent le sevrage
- éruption cutanée avec plaques rouges aux points de pression et fragilité cutanée: fissures des plis, ulcérations, voir escarres
- altération des cheveux et troubles digestifs et des œdèmes au niveau des MI
- abdomen distendu par ascite et déficit pondéral masqué par les œdèmes
- modification du comportement: l'enfant ne joue pas et refuse la nourriture et ne s'intéresse pas à son entourage (enfant craintif)

- **les indicateurs de la santé maternelle:**
 - taux d'accouchements en milieu surveiller
 - taux d'accouchements en milieu rural
 - taux de césariennes
 - taux de consultations prénatales
 - taux de consultations du post-partum
 - **les actions de l'état en matière de santé portent sur les domaines suivants:**
 - prévention contre les risques menaçant la santé
 - éducation pour la santé
 - promotion des modes de vie sains
 - contrôle sanitaire
 - prestations de soins préventifs, curatif ou palliatifs et de réhabilitation
- missions du REH: disposer avec ou sans hébergement des prestations de diagnostic, de soins et de services aux malades, parturientes et blessés

- **les missions du REH:** disposer avec ou sans hébergement des prestations de diagnostic, de soins et de services aux malades, parturientes et blessés
- ❖ **ils concourent aux actions**
 - de médecine préventive et d'éducation pour la santé
 - d'assistance médicale urgente
 - de formations pratiques des étudiants
 - de formations continues des professionnels et de gestionnaires de santé
- ❖ **contribue au:** développement de la recherche en santé publique et d'économie de la santé ou d'administration sanitaire.
- **les oreillons:** ou parotidite virale ou encore parotidite épidémique est une maladie virale infantile humaine atteinte principalement les glandes salivaires situées en avant des oreilles ainsi que le tissu nerveux.
- **l'origine de la grippe AH1N1:** est porcine, aviaire, humaine.
- **Définition du SNS:**
 - **Selon l'OMS:** Un système de santé inclut toutes les activités dont le but essentiel est de promouvoir, restaurer ou entretenir la santé.»
 - **Selon MS:** Ensemble des ressources Humaines, Matérielles, Financières, Institutions, Activités destinées à assurer la promotion, la protection, la restauration et la réhabilitation de la santé de la population ».

- **Qualités d'un système de santé:** Global; Efficace; Accessible; Acceptable; Equitable; Planifiable et évaluable; Souple et modifiable
- **les OMD 3 liées directs à la santé:**

☞ Objectif 4 : réduire la mortalité infantile

☞ Objectif 5 : améliorer la santé maternelle

☞ Objectif 6 : combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies

☞ Autres objectifs liés à la santé :

- Objectif 1 : éliminer l'extrême pauvreté et la faim
- Objectif 7 : préserver l'environnement

les ODD: sont au nombre de 17:

l'objectif 3 du DD: donner les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien être de tous et à tous les ages (il énonce 9 cibles mesurables devant être atteintes d'ici 2030):

- C3,1: faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au dessous de 70 pour 100000 nv.
- C3,2: éliminer les décès évitables des n.né et d'enfants de - 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1000 NV au plus et la mortalité des enfants de -5 ans à 25 pour 1000 NV au plus.
- C3,3: mettre fin à l'épidémie de sida, à la TB, au paludisme, et aux maladies tropicales négligées, et combattre l'hépatite, les maladies transmissibles par l'eau et autres MT.
- C3,4: réduire 1/3 par la prévention et le ttt le taux de mortalité prématurée dès à des maladies non trans et promouvoir la santé mentale et le bien être

- C3,5: renforcer la prévention et le ttt de l'abus de substances psychoactives (alcool, stupéfiant)
- C3,6: diminuer la de moitié à l'échelle mondiale le nombre de décès et de blessure dès à des accidents de la route
- C3,7: assurer l'accès de tous à des sces de sois de santé sexuelle et procréative
- 3,8: faire en sorte que chacun bénéficie d'une assurance santé comprenant une protection contres les risques financiers et donnat accès à des sces de qualité et des médicaments et vaccins essentiels surs, efficace, de qualité et d'un cout abordable
- 3,9: rduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à la pollution et à la contamination de l'air de l'eau et du sol.

• **D. de l'information et de la communication:** se compose de 3scs:

- Le service de la communication institutionnelle
- le service de l'information et de l'éducation sanitaire
- le service de production des supports d'information et de communication

• **La préparation d'un biberon de lait de 120 ml nécessite :**

- A- Le lavage des mains
- B- Un biberon stérilisé
- C- Quatre cuillères mesure rase de lait en poudre
- D- 120 ml d'eau

- **PRINCIPAUX TYPES D'ENQUÊTES**

- ❖ Selon la population étudiée:

les études exhaustives: totalité de la population étudiée.

Les études par échantillonnage: l'étude d'une partie de la population source

- ❖ Selon la durée de l'enquête:

- Les études transversale: investigations de courte durée.
- Les études longitudinales: investigations répétées, prolongées dans le temps,
- Les études permanentes: se poursuivent de façon indéfinie

- ❖ Selon la chronologie de l'enquête:

- Enquête rétrospective: l'événement recherché s'est déjà produit
- Enquête prospective: l'événement ne s'est pas encore produit

- ❖ Selon l'élément de départ (l'exposition):

- L'enquête cas-témoins: L'élément de départ est l'issue, en suite on cherche l'exposition.
- Les enquêtes de cohorte: L'élément de départ est l'exposition, en suite on cherche l'issue.

les complications aiguës du diabète sont :

- a. le coma acidocétosique
- b. le coma hypoglycémique
- c. l'acidose lactique
- d. le coma hyperosmolaire

la composition du conseil des infirmiers et infirmière:

- d'une moitié est composé du responsable du PSI, des infirmiers chefs aux départements, des infirmiers chefs aux sces.
- pour l'autre moitié est composé des élus du personnel infirmier, des techniciens et des assistants médicaux lorsqu'ils existent
- les membres du conseil élisent parmi eux un président sur la base de sa notoriété professionnelle.
- il est chargé: d'apprécier la qualité et la pertinence des SI, contribuer à la FC, donner son avis sur les questions relatives à la prestations des SI PAR l'hôpital
- son secrétariat est assurée par le chef du PSI il se renouvèle chaque trimestre.
- **le syndrome de Wolkman:** complication du syndrome de loge se manifeste par: une atteinte musculaire (nerveuse; artérielle, veineuse).il existe d'autres causes des syndrome de Wolkman:(luxation, brûlure 3ème D; fracture, et plâtre).

les objectifs du plan stratégique national 2017-2021 de lutte contre le sida:

- diminuer de 75% les nouvelles infections par VIH
- diminuer de 60% la mortalité liée à l'infection par le VIH
- éliminer la transmission mère-enfant du VIH
- lutter contre toute forme de discrimination et de stigmatisation
- **la fréquentation des HP a augmenté de:** 80% (10,77 millions en 2016 contre 6 millions en 2008)
- **la SS 2017-2021 prévoit le renforcement de l'accès aux soins par:**
 - l'augmentation de la CL globale par 10327 lits supplémentaires
 - le renforcement de la santé mobile par 331 unités mobiles et 394 ambulances
 - la mise en œuvre de la carte sanitaire et publication de ces textes d'application (SROS)
 - amélioration de l'accès aux médicaments et dispositifs médicaux
- **Renforcement de la riposte contre les zoonoses majeures et les maladies négligées**
 - Mise en œuvre du plan d'action de lutte contre les leishmanioses selon une approche décentralisée et participative ;
 - Contrôle des leishmanioses au niveau national en vue de réduire leur incidence de 75% au terme de l'année 2016 ;
 - Elaboration et mise en œuvre d'un plan intégré multisectoriel de prévention et de lutte contre les zoonoses majeures.

- **Q) Les objectifs de la CS:**

- L'optimisation de l'utilisation des ressources stratégiques du Système de Santé national
- La détermination du cadre le plus approprié à MT et à LT pour le développement
- des différentes composantes de l'offre de soins (l'infrastructure de base, les équipements biomédicaux et les ressources humaines), publiques et privées ;
- Améliorer l'accès au soins et réduire les inégalités
- Rationnaliser le développement sanitaire du pays
- Déterminer le cadre adéquat pour le développement des (infrastructures, équipement, RH ...)
- Régulation de l'offre de soins

Q) selon le décret de la CS,: la carte:

- Est un outil de l'organisation de l'offre de soins
- Est établie par arrêté du ministre de la santé
- Est établie pour une période de 10 ans
- Doit être évaluée tous les 5 ans
- Vise l'optimisation de l'utilisation des ressources par le système de santé

Q) le décret de la CS: ne s'applique pas aux:

- Structures sanitaires régies par des textes législatifs et réglementaires spécifiques
- Bureaux communaux d'hygiène et de tout service sanitaire ayant pour mission de exclusive de fournir des prestations de santé publique visant la prévention sanitaires collective

les composantes du SROS:

- Un plan stratégique régional
- Un plan de couverture sanitaire
- Un plan thématique
- Un plan d'effectif
- Un plan de communication

www.ispits.net

la commission régionale de l'offre de soins: donne son avis pour l'élaboration des SROS.

- Est présidée par la wali de la région concernée ou son représentant
- Son secrétariat est assurée par la DR de la santé de la région concernée

Q) le schéma régional de l'offre de soins (SROS) est :

- Établis par les DR de la santé concernées pour une période de 5 ans après avis de la CROS.
- Approuvées par des arrêtés des ministre de la santé.
- L'établissement d'une stratégie de développement des activités sanitaires
- est construit sur la base de l'analyse des besoins de santé de la population et leurs tendances.
- La définitions des besoins en ressources humaines
- Une référence pour l'allocation optimale des ressources
- Un outil pour la détermination des objectifs prioritaires en matière de santé

- **Q) L'organisation de l'offre de soins est effectuée conformément à:**

- CS
- SROS

- **Q) L'offre de soins:** est régie par le principe de gradation des niveaux de soins qui repose sur un système de référence et de contre référence qui régule les parcours des soins des patients en dehors des situations d'urgence. Ce système de soins sous forme de réseau coordonné de soins dans le même territoire ou filière de soins entre les territoires sanitaires

- **les principes des SROS:**

- Globalité
- Intégration
- Proximité
- Équité
- viabilité

www.ispits.net

- Q) L'offre de soins au Maroc** est organisé en 2 secteurs:

- Secteur formel
- Secteur informel

- Q) 3 régimes de CMB :**

1. AMO (y compris l'AMI) gérée par (CNOPS - CNSS - assurances privées)
2. RAMED gérée par (ANAM)